

Buku Ajar **KOMUNIKASI KEPERAWATAN**

Enik Suhariyanti • Erna Juliana Simatupang • Aemilianus Mau

Editor: Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.



BUKU AJAR

KOMUNIKASI KEPERAWATAN

Penulis:

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Erna Juliana Simatupang, S.ST.

Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.



BUKU AJAR KOMUNIKASI KEPERAWATAN

Penulis:

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep.
Erna Juliana Simatupang, S.ST.
Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-88-6

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga “buku ajar Komunikasi Keperawatan” ini dapat disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan.

Komunikasi merupakan salah satu kemampuan dasar yang sangat penting dalam praktik keperawatan. Seorang perawat tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pasien, keluarga, sesama tenaga kesehatan, dan lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, proses pemberian asuhan keperawatan dapat berlangsung dengan lebih baik, kebutuhan pasien dapat dipahami secara menyeluruh, serta hubungan saling percaya antara perawat dan pasien dapat terbentuk.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar komunikasi dalam keperawatan, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik, teknik komunikasi dengan pasien, keluarga, kelompok, dan tim kesehatan, serta penerapan komunikasi dalam berbagai situasi pelayanan keperawatan. Pembahasan dalam buku ini juga mencakup hambatan komunikasi, etika komunikasi, komunikasi pada kondisi khusus, serta pentingnya empati, mendengarkan aktif, dan sikap profesional dalam berinteraksi dengan pasien.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran baik secara mandiri maupun dalam kegiatan perkuliahan. Selain memberikan pemahaman teoritis, buku ini juga diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk menerapkan keterampilan komunikasi secara nyata dalam praktik keperawatan, baik di ruang kelas, laboratorium, maupun di lahan praktik klinik.

Penyusunan buku ajar Komunikasi Keperawatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kemampuan komunikasi sebagai bagian integral dari pelayanan keperawatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dengan komunikasi yang baik, perawat dapat memberikan dukungan emosional, membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kerja sama dalam proses perawatan dan penyembuhan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman materi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, dan seluruh pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai komunikasi dalam praktik keperawatan.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENGANTAR KOMUNIKASI KEPERAWATAN: PERAN, TUJUAN, DAN DAMPAKNYA PADA KESELAMATAN PASIEN 1

A. Definisi dan Konsep Komunikasi Keperawatan.....	4
B. Peran Komunikasi dalam Keselamatan Pasien (Patient Safety)	4
C. Tahapan dan Fase Hubungan Terapeutik.....	4
D. Implementasi Teknik Komunikasi Efektif SBAR.....	5
E. Etika, Hambatan, dan Legalitas dalam Komunikasi Klinis	5
F. Aktivitas 1 — Knows How.....	6
G. Aktivitas 2 — Shows How	6
H. Aktivitas 3 — Psychomotor Skills (Keterampilan Klinis).....	7
I. Template Soal Osce Keperawatan	12
J. Portofolio	30
K. Ringkasan	35
L. Tabel Red Flags & Eskalasi	36
M. Daftar Pustaka.....	39

BAB 2 KETERAMPILAN WAWANCARA KEPERAWATAN: ANAMNESIS, ACTIVE LISTENING, DAN EMPATI.....41

A. Konsep Keterampilan Wawancara Keperawatan.....	46
B. Anamnesis	49
C. Keterampilan Mendengarkan.....	49
D. Active Listening	50
E. Empati.....	54
F. Aktivitas 1: Knows How.....	56
G. Aktivitas 2 — Shows How	56
H. Soal Osce Keperawatan	61
I. Ringkasan	89
J. Tabel Red Flags & Eskalasi	91
K. Daftar Pustaka.....	96

BAB 3 KOMUNIKASI INTERPROFESIONAL DAN KOLABORASI TIM KESEHATAN	97
A. Konsep Komunikasi Interprofesional.....	99
B. Konsep Kolaborasi Interprofesional.....	100
C. Model Komunikasi Efektif dalam Kolaborasi Interprofesional	100
D. Komunikasi antara perawat dengan dokter.....	102
E. Komunikasi Perawat dengan Ahli Terapi.....	103
F. Komunikasi Perawat dengan Ahli Farmasi.....	106
G. Komunikasi Perawat dengan Ahli Gizi.....	109
H. Perilaku Disruptif dalam Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan.....	112
I. Evidence-Based Practice: Persepsi Hubungan Perawat–Dokter pada Unit Medikal Bedah dan ICU	114
J. Hambatan dalam Komunikasi Antarprofesi dalam Tim Kesehatan	117
K. Prinsip Komunikasi dalam Kasus Pemicu pada Pelayanan Multidisiplin	120
L. Ringkasan	126
M. Daftar Pustaka.....	127
 PROFIL PENULIS	 129

BAB 1

PENGANTAR KOMUNIKASI KEPERAWATAN: PERAN, TUJUAN, DAN DAMPAKNYA PADA KESELAMATAN PASIEN

Identitas Bab

- **Mata Kuliah:** Komunikasi Keperawatan I
- **Beban Studi:** 2 SKS
- **Sasaran Pembelajaran:** Mahasiswa Tahap Akademik Program Studi Sarjana Keperawatan
- **Deskripsi Singkat:** Bab ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar mengenai peran strategis dan tujuan komunikasi terapeutik dalam tatanan pelayanan kesehatan, serta dampaknya yang signifikan terhadap pencegahan *medical error* guna menjamin keselamatan pasien (*patient safety*).

Capaian Pembelajaran (Obe)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran dan tujuan komunikasi terapeutik, serta mendemonstrasikan koordinasi asuhan yang aman bagi keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Tabel Matriks Capaian Pembelajaran

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Metode Asesmen & Level Miller
CPL-02	Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik profesi.	CPMK-1	Mahasiswa mampu menganalisis konsep komunikasi terapeutik dan hubungannya dengan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>).	Sub-CPMK 1.1: Mampu menguraikan prinsip mendasar, peran, dan tujuan komunikasi terapeutik	Tes Tertulis & Analisis <i>Mini-Case</i> kelompok (Level: Knows How).

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Metode Asesmen & Level Miller
				dalam pelayanan keperawatan. Sub-CPMK 1.2: Mampu menganalisis korelasi antara kegagalan komunikasi dengan insiden keselamatan pasien.	
CPL-03	Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada tim kesehatan.	CPMK-2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik komunikasi efektif SBAR dan TBaK dalam tim interprofesional.	Sub-CPMK 2.1: Mampu merancang alur komunikasi tim interprofesional menggunakan komponen SBAR secara akurat. Sub-CPMK 2.2: Mampu memperagakan verifikasi instruksi verbal	Ujian <i>Simulated Skills Lab</i> / OSCE Ringkas (Level: Shows How).

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Metode Asesmen & Level Miller
				telepon dengan metode TBaK.	
CPL-08	Mampu mendemonstrasikan perilaku profesional dan kerja sama dalam tim interdisiplin kesehatan.	CPMK-3	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme dalam tahap-tahap komunikasi keperawatan.	Sub-CPMK 3.1: Mampu menampilkan respons empati (verbal dan non-verbal) secara konsisten pada setiap fase komunikasi terapeutik.	Penilaian Praktik Nyata / Mini-CEX di Lahan Klinik (Level: Does).

Peta Konsep



Tabel 1.1 Matriks Capaian Pembelajaran

Uraian Materi

A. Definisi dan Konsep Komunikasi Keperawatan

Komunikasi keperawatan bukan sekadar pertukaran kata-kata, melainkan sebuah proses yang disengaja, terstruktur, dan memiliki tujuan klinis yang jelas. Komunikasi ini merupakan instrumen utama dalam membangun hubungan terapeutik, sebuah kemitraan antara perawat dan pasien yang didasarkan pada rasa saling percaya, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Arnold & Boggs, 2020). Berbeda dengan komunikasi sosial, komunikasi keperawatan memiliki batasan profesional yang ketat di mana fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan pasien. Perawat dituntut untuk memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi agar mampu menangkap pesan verbal maupun non-verbal yang disampaikan oleh pasien dalam kondisi rentan (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).

B. Peran Komunikasi dalam Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Dalam pelayanan kesehatan modern, efektivitas komunikasi adalah penentu utama keselamatan pasien. Berbagai laporan kejadian sentinel menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi saat serah terima pasien (*handover*) merupakan akar penyebab utama terjadinya kesalahan medis, seperti kesalahan pemberian dosis obat atau keterlambatan penanganan kondisi kritis. Komunikasi yang tidak terstandar seringkali menyebabkan informasi penting "hilang" di tengah proses transisi perawatan. Oleh karena itu, penerapan protokol komunikasi yang disiplin berfungsi sebagai *barrier* atau pelindung untuk mencegah terjadinya *medical error* dan memastikan kesinambungan asuhan yang aman bagi pasien (Stewart & Hand, 2017).

C. Tahapan dan Fase Hubungan Terapeutik

Hubungan antara perawat dan pasien harus berjalan secara sistematis melalui empat fase yang saling berkaitan untuk menjamin efektivitas asuhan (Kourkouta & Papathanasiou, 2014):

1. Fase Pra-interaksi: Tahap internal di mana perawat melakukan persiapan diri, mengeksplorasi kecemasan pribadi, dan mempelajari data pasien sebelum pertemuan pertama terjadi demi meminimalkan bias.
2. Fase Orientasi: Tahap krusial untuk membangun *rapport* atau rasa percaya. Di sini perawat memperkenalkan peran, menetapkan kontrak waktu, dan menyepakati tujuan jangka pendek serta jangka panjang bersama pasien.

3. Fase Kerja: Merupakan inti dari hubungan terapeutik di mana perawat dan pasien bekerja sama mengatasi masalah kesehatan. Teknik seperti mendengarkan aktif (*active listening*), memberikan umpan balik, dan melakukan klarifikasi digunakan secara intensif untuk mencapai target kesehatan.
4. Fase Terminasi: Tahap pengakhiran yang dilakukan saat tujuan tercapai atau masa tugas perawat berakhir. Fokusnya adalah melakukan evaluasi hasil belajar pasien dan merencanakan kemandirian pasien di masa mendatang.

D. Implementasi Teknik Komunikasi Efektif SBAR

SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) adalah kerangka kerja komunikasi yang dirancang untuk memastikan informasi klinis yang kritis tersampaikan secara akurat dan ringkas di antara tenaga profesional kesehatan (Stewart & Hand, 2017):

1. Situation (S): Memberikan gambaran instan tentang kondisi saat ini, mencakup identitas pasien dan alasan spesifik mengapa pelaporan dilakukan.
2. Background (B): Menyajikan data pendukung yang relevan seperti diagnosa medis masuk, riwayat alergi, dan intervensi yang sudah diberikan sebelumnya.
3. Assessment (A): Menyampaikan hasil pemikiran kritis perawat berdasarkan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital terbaru mengenai apa yang sedang terjadi pada pasien.
4. Recommendation (R): Menyebutkan tindakan apa yang diharapkan perawat dari rekan sejawat atau dokter, seperti permintaan pemeriksaan penunjang atau perubahan terapi segera.

E. Etika, Hambatan, dan Legalitas dalam Komunikasi Klinis

Perawat sering menghadapi hambatan komunikasi yang kompleks, mulai dari gangguan sensorik pada pasien (seperti tuli), kendala bahasa, hingga kondisi emosional pasien yang sangat tidak stabil. Selain keterampilan teknis, aspek etika seperti *Confidentiality* (kerahasiaan) menjadi harga mati. Informasi yang disampaikan melalui metode SBAR atau catatan medis adalah rahasia profesional yang hanya boleh diakses oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan asuhan pasien. Pelanggaran terhadap privasi pasien dalam berkomunikasi tidak hanya mencederai kepercayaan pasien tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi tenaga kesehatan (O'Daniel & Rosenstein, 2011).

F. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan diare sejak kemarin. Ibu pasien tampak sangat cemas karena anaknya BAB cair >8 kali dan mulai terlihat lemas. Hasil pengkajian awal: suhu 38,2°C, nadi 120 x/menit, frekuensi napas 26 x/menit, mukosa mulut kering, mata cekung ringan, turgor kulit menurun, CRT 2 detik, dan urin sedikit. Berdasarkan data subjektif dan objektif pada kasus An. D di atas, diagnosis keperawatan yang ditegakkan adalah Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif (Diare) (PPNI, 2017).

Perawat Ners A perlu melakukan komunikasi terapeutik kepada Ibu pasien untuk menjelaskan rencana pemasangan infus dan selanjutnya melaporkan kondisi penurunan volume cairan ini kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) menggunakan teknik SBAR.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut, diskusikan strategi komunikasi yang paling tepat untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas asuhan.

Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimanakah teknik komunikasi terapeutik yang tepat saat mendekati Anak D yang sedang rewel (fase orientasi)?
2. Susunlah draf komunikasi SBAR untuk melaporkan kondisi "Hipovolemia" Anak D kepada DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) via telepon!
3. Sebutkan hambatan komunikasi yang mungkin muncul saat berhadapan dengan orang tua yang sedang cemas melihat anaknya dehidrasi!

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

G. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab pendidikan kesehatan

Instruksi: Bentuklah berpasangan (satu menjadi perawat, satu menjadi orang tua pasien). Simulasikan pemberian pendidikan kesehatan tentang "Penanganan Diare di Rumah dan Pencegahan Dehidrasi". Fokus utama penilaian adalah kemampuan perawat menggunakan bahasa yang non-medis (mudah dipahami) dan teknik komunikasi terapeutik pada orang tua yang cemas.

H. Aktivitas 3 — Psychomotor Skills (Keterampilan Klinis)

"Penilaian kompetensi klinis ini mengacu pada kerangka kerja Miller's Pyramid (1990) untuk menilai tahap *Shows How* (mendemonstrasikan) (Miller, 1990).

Prosedur Pembuatan Larutan Gula Garam (Lgg) Dan Oralit

Indikasi: Diberikan Pada Anak Dengan Diare Untuk Mencegah Dan Mengatasi Dehidrasi ringan di rumah, bahwa manajemen rehidrasi pada balita dilakukan sesuai standar penanganan diare untuk mencegah dehidrasi berat (WHO, 2005).

1. Asesmen (Piramida Miller) (Miller, 1990):

Tabel Matriks Kompetensi Komunikasi Keperawatan Anak

Level	Materi Kompetensi	Metode Evaluasi
Knows	Konsep dehidrasi dan prinsip komunikasi anak	MCQ / Ujian Tulis
Knows How	Analisis SBAR pada kasus diare anak	Case Based Discussion
Shows How	Simulasi edukasi ke orang tua & pelaporan SBAR	OSCE / Skill Lab
Does	Komunikasi langsung di bangsal anak	Logbook Klinik

2. OSCE Ringkas + Critical Items

a. Critical Items (WAJIB LULUS)

Mahasiswa dinyatakan **Gagal/Tidak Lulus** pada stase ini apabila tidak melakukan atau salah dalam poin-poin berikut:

- 1) Identifikasi Pasien: Gagal melakukan verifikasi identitas pasien (Ananda D) dan keluarga sebelum memulai komunikasi atau tindakan.
- 2) Ketepatan Pelaporan SBAR: Salah memberikan informasi pada komponen Situation (misal: salah menyebutkan jumlah BAB atau status dehidrasi) yang berisiko pada kesalahan instruksi dokter.
- 3) Keamanan Prosedur (*Patient Safety*): Salah menyebutkan atau mendemonstrasikan perbandingan dosis Larutan Gula Garam (LGG) yang dapat memperburuk kondisi elektrolit anak (1 sdt gula, 1/4 sdt garam dalam 200ml air).
- 4) Eskalasi Red Flags: Gagal mengenali dan melaporkan tanda bahaya segera (seperti anak sangat lemas/letargi atau mata sangat cekung) saat melakukan observasi.
- 5) Etika & Privasi: Tidak melakukan cuci tangan (*hand hygiene*) atau tidak menjaga kerahasiaan informasi pasien saat berkomunikasi di area publik

b. Metode Evaluasi OSCE

Tabel Format Skenario Station OSCE

No	Komponen	Rincian Instruksi
1	Nomor Station	2 (Dua)
2	Judul Station	Komunikasi SBAR & Edukasi Keluarga pada Kasus Diare Anak
3	Alokasi Waktu	15 Menit
4	Tingkat Kesulitan	Mahir
5	Tujuan Station	Menguji kemampuan mahasiswa dalam edukasi keluarga dan pelaporan kondisi kritis
6	Instruksi Penguji	Amati kemampuan mahasiswa dalam melakukan pendekatan atraumatik pada anak dan ketepatan SBAR.
7	Instruksi Peserta	1. Berikan edukasi pada Ibu pasien tentang tanda dehidrasi. 2. Lakukan lapor dokter via telepon terkait kondisi pasien.
8	Instruksi Klien Standar	Ibu pasien (Aktor) berperan cemas, sering memotong pembicaraan karena khawatir anaknya tidak mau makan.
9	Peralatan	Manekin anak, lembar balik edukasi diare, telepon, rekam medis.
10	Setting	Ruang Rawat Inap Anak
11	Penulis Soal	Tim Akademik Komunikasi Keperawatan
12	Referensi	SDKI (2017), Arnold & Boggs (2020)
13	Kriteria Lulus	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami keluarga dan data SBAR akurat.

c. Cuplikan Rubrik

Tabel Checklist Prosedur Komunikasi SBAR & TBaK

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Ya	Tidak
1	Persiapan: Cek rekam medis & hasil Lab terbaru	10		
2	Situation: Menyebutkan Nama, Ruangan, Nama Pasien, Diagnosa Medis & Masalah (Hipovolemia)	20		
3	Background: Menyebutkan riwayat diare, jumlah BAB, dan terapi cairan saat ini	20		
4	Assessment: Menyebutkan hasil TTV dan tanda dehidrasi terbaru	20		

5	Recommendation: Meminta advis dokter (misal: penambahan tetesan infus)	20
6	TBaK: Mencatat, Membaca Ulang, dan Mengonfirmasi instruksi dokter	10

Tabel Indikator Penilaian Performa

Skor	Kriteria Kinerja
3 (Mahir)	Komunikasi lancar, empati tinggi, data SBAR lengkap dan akurat.
2 (Cukup)	Komunikasi cukup baik, namun ada 1 komponen SBAR yang terlewat.
1 (Kurang)	Mahasiswa tampak gugup, tidak menggunakan terminasi, data tidak akurat.

3. Sop Pendidikan Kesehatan (Pendkes) Pada Keluarga

Tabel Checklist Prosedur Komunikasi Edukasi Keluarga

No	Langkah-Langkah Komunikasi Edukasi	Ya	Tidak
I	TAHAP ORIENTASI		
1	Memberikan salam terapeutik dan memanggil nama Ibu/Keluarga		
2	Menjelaskan tujuan pertemuan (Edukasi penanganan diare)		
3	Validasi perasaan orang tua (Empati terhadap kecemasan ibu)		
II	TAHAP KERJA (PROSES EDUKASI)		
4	Menggunakan media (Leaflet/Lembar Balik) dengan posisi duduk sejajar		
5	Menjelaskan tanda bahaya dehidrasi dengan bahasa sederhana		
6	Mendemonstrasikan cara pemberian oralit atau larutan gula garam		
7	Memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya (Komunikasi dua arah)		
III	TAHAP TERMINASI		
8	Mengevaluasi pemahaman keluarga (Meminta ibu mengulang penjelasan)		
9	Menyepakati rencana tindak lanjut (Kapan harus lapor perawat)		

10	Berpamitan secara sopan dan memberikan reinforcement positif
-----------	--

4. RUBRIK PENILAIAN KOMUNIKASI EDUKASI

(untuk menilai aspek "soft skill" perawat)

Tabel Rubrik Penilaian Komunikasi Terapeutik & Edukasi

Komponen	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Empati	Menunjukkan kepedulian tinggi secara verbal & non-verbal.	Empati terlihat tapi kurang konsisten.	Mengabaikan perasaan orang tua/kaku.
Bahasa	Menggunakan istilah yang sangat mudah dipahami awam.	Masih menggunakan 1-2 istilah medis tanpa penjelasan.	Terlalu banyak istilah medis (jargon).
Media	Menggunakan media secara interaktif dan menarik.	Menggunakan media tapi hanya dibaca saja.	Tidak menggunakan media sama sekali.

Tabel Checklist Observasi Keterampilan Psikomotor : Pembuatan LGG

No	Langkah Prosedur	Bobot	Dilakukan (1)	Tidak (0)
I	PERSIAPAN ALAT & BAHAN			
1	Gelas berisi air matang (200 ml)	5		
2	Gula pasir dan Garam dapur (atau bungkus Oralit)	5		
3	Sendok teh bersih	5		
II	TAHAP KERJA (KOMUNIKASI & TINDAKAN)			
4	Komunikasi: Menjelaskan pada ibu pentingnya rehidrasi oral	15		
5	Mencuci tangan sebelum memulai prosedur	10		
6	Tindakan: Memasukkan 1 sendok teh gula pasir (peres) ke air	15		
7	Tindakan: Memasukkan 1/4 sendok teh garam dapur ke air	15		
8	Tindakan: Mengaduk hingga larut sempurna	10		
III	EVALUASI & EDUKASI			

9	Komunikasi: Menjelaskan cara pemberian sedikit demi sedikit tapi sering	10
10	Komunikasi: Menjelaskan kapan larutan harus dibuang (setelah 24 jam)	10

5. Rubrik Penilaian Psikomotor

Tabel Kriteria Kelulusan Keterampilan Teknis

Nilai	Keterangan
81 - 100 (A)	Mahasiswa sigap, komposisi campuran tepat, dan komunikasi ke keluarga sangat jelas.
61 - 80 (B)	Mahasiswa mampu membuat larutan dengan benar, namun komunikasi masih kaku.
< 60 (E)	Mahasiswa salah dalam komposisi gula/garam atau tidak mencuci tangan.

Tabel Kriteria Keselamatan Pasien

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	& Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen keputusan	& Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

I. Template Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Diare
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pemberian oralit pada anak dengan diare.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan diare sejak kemarin. Ibu pasien tampak sangat cemas karena anaknya BAB cair >8 kali dan mulai terlihat lemas. Hasil pengkajian awal: suhu 38,2°C, nadi 120 x/menit, frekuensi napas 26 x/menit, mukosa mulut kering, mata cekung ringan, turgor kulit menurun, CRT 2 detik, dan urin sedikit. Diagnosa: Hipovolemia.

No.	Komponen	Isi
		TUGAS: 1. Lakukan edukasi dengan menerapkan komunikasi terapeutik (edukasi) kepada Ibu pasien mengenai tanda dehidrasi dan cara pemberian oralit/LGG. 2. Lakukan pelaporan kondisi pasien kepada dokter penanggung jawab (DPJP) menggunakan teknik SBAR melalui telepon.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan diare sejak kemarin. Ibu pasien tampak sangat cemas karena anaknya BAB cair >8 kali dan mulai terlihat lemas. Hasil pengkajian awal: suhu 38,2°C, nadi 120 x/menit, frekuensi napas 26 x/menit, mukosa mulut kering, mata cekung ringan, turgor kulit menurun, CRT 2 detik, dan urin sedikit. Diagnosa: Hipovolemia. TUGAS: 1. Lakukan edukasi dengan menerapkan komunikasi terapeutik (edukasi) kepada Ibu pasien mengenai tanda dehidrasi dan cara pemberian oralit/LGG. 2. Lakukan pelaporan kondisi pasien kepada dokter penanggung jawab (DPJP) menggunakan teknik SBAR melalui telepon. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Mengamati interaksi peserta dengan Ibu pasien (Probandus) dan ketepatan teknik SBAR.

No.	Komponen	Isi
		2. Memberikan penilaian pada lembar skor berdasarkan rubrik. 3. Critical Point: Penguji wajib memastikan peserta melakukan identitas pasien dan menyebutkan dosis LGG dengan benar. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan, menjelaskan cara melarutkan oralit sesuai petunjuk kemasan, menjelaskan pemberian sedikit demi sedikit, menjelaskan anjuran pemberian setelah BAB cair, serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: anak laki-laki usia 2 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: anak BAB cair sejak kemarin sebanyak 6 kali, muntah 2 kali, tidak ada darah pada tinja, anak tampak lemas, rewel, dan minum sedikit. 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: ibu tampak cemas, anak rewel, lebih sering ingin digendong, dan belum nyaman dengan lingkungan rumah sakit. 6. Harapan terhadap penyakit: ibu berharap anak segera membaik, tidak lemas, dan dapat minum seperti biasa.

No.	Komponen	Isi
		7. Bila peserta menanyakan BAK, jawaban KS: sejak pagi anak baru BAK 1 kali dan jumlahnya sedikit. 8. Bila peserta menanyakan asupan makan dan minum, jawaban KS: anak tidak mau makan, hanya minum sedikit-sedikit. 9. KS Tampak gelisah, mondar-mandir di samping tempat tidur anak. Sering memotong pembicaraan perawat dengan pertanyaan: "Anak saya kenapa lemas sekali, Sus? Apa perlu infus ditambah?" Anak dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian. Instruksi Khusus: Jika perawat menjelaskan dengan istilah medis yang sulit (misal: "hipovolemia"), Probandus harus bertanya: "Aduh, itu maksudnya apa ya, Sus?" (Menguji kemampuan komunikasi perawat).
10	Setting station	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS

No.	Komponen	Isi
		3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok/tempat muntah 5. Pengalas 6. Oralit sachet 7. Air matang dalam gelas ukur sesuai kebutuhan pelarutan 8. Gelas/cangkir kecil 9. Sendok teh atau spuit oral 10. Lembar jawaban pesertaLaboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PEMBERIAN ORALIT PADA ANAK DENGAN DIARE

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Oralit sachet d. Air matang sesuai petunjuk kemasan e. Gelas ukur/wadah bersih f. Gelas/cangkir/sendok atau spuit oral g. Tisu h. Bengkok/pengalas bila perlu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengidentifikasi frekuensi BAB cair, muntah, intake cairan, jumlah urin, dan tanda dehidrasi				
14	Mengidentifikasi kemampuan anak untuk minum dan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	kesiapan ibu menerima edukasi				
15	Mengatur posisi anak nyaman, dapat dipangku ibu atau posisi duduk/semi-Fowler sesuai kondisi				
16	Menjelaskan tujuan pemberian oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang				
17	Memeriksa oralit dan menyiapkan air matang sesuai petunjuk kemasan				
18	Mendemonstrasikan cara melarutkan oralit sesuai petunjuk kemasan sampai larut homogen				
19	Menjelaskan dan mendemonstrasikan pemberian oralit sedikit demi sedikit menggunakan sendok/cangkir/spuit oral				
20	Menjelaskan bahwa bila anak muntah, pemberian dihentikan 5–10 menit lalu dilanjutkan perlahan				
21	Menganjurkan pemberian oralit setiap selesai BAB cair dan sesuai toleransi anak				
22	Menganjurkan tetap melanjutkan ASI dan makanan sesuai usia serta toleransi anak				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
23	Menjelaskan bahwa larutan oralit yang sudah dibuat hanya digunakan maksimal 24 jam, sisanya dibuang				
24	Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan atau dibawa ke fasilitas kesehatan: anak tidak mau minum, muntah terus, BAB berdarah, demam tinggi, sangat lemas, kejang, mata makin cekung, atau BAK sangat sedikit				
25	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
26	Meminta ibu mendemonstrasikan kembali cara pemberian oralit dengan benar				
27	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
28	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DIARE

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali frekuensi BAB, muntah, intake cairan, jumlah urin, dan tanda dehidrasi					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan oralit, menyiapkan dan melarutkan oralit dengan benar, mendemonstrasikan cara pemberian, serta menjelaskan tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DIARE

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan diare, meliputi frekuensi dan karakteristik BAB, frekuensi muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, serta respons anak dan ibu terhadap kondisi sakit. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik anak dengan diare serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi pemberian oralit pada anak dengan diare dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku ProfesionalAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus anak diare.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi BAB, muntah, intake cairan, dan urin, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi/karakteristik BAB, muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, serta respons anak dan ibu, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		terbatas dan tidak relevan.	masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara melarutkan oralit, cara pemberian sedikit demi sedikit, tindakan saat anak muntah, anjuran melanjutkan cairan/ASI, tanda bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	an privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
 Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada anak yang mengalami diare di ruang perawatan anak.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang diare, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi anak, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang anak usia 3 tahun dirawat dengan diare sejak dua hari, BAB cair 6 kali, muntah 2 kali, mukosa mulut kering, mata sedikit cekung, dan tampak lemas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda dehidrasi, menjelaskan kondisi kehilangan cairan, lalu menyampaikan rencana pemantauan hidrasi, pemberian cairan oral, observasi diare dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		muntah, serta edukasi tentang oralit dan tanda bahaya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali frekuensi diare, muntah, intake cairan, jumlah urin, mengenali tanda dehidrasi, menjelaskan oralit dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya defisit volume cairan, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda dehidrasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian intake-output dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan diare, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

J. Portofolio

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan anak dengan diare, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat anak dengan diare, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian oralit, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada anak dengan diare di ruang rawat anak.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus anak usia 3 tahun dengan diare, frekuensi BAB cair, muntah, tanda dehidrasi, diagnosis keperawatan prioritas,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		intervensi hidrasi, edukasi oralit, dan evaluasi respons anak.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda dehidrasi, mencatat intake-output dengan teliti, memastikan oralit diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak dan edukasi oralit, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian jumlah urin dan dokumentasi cairan masuk-keluar.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus diare, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian dehidrasi, edukasi oralit, dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		komunikasi terapeutik dengan keluarga anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan diare, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep diare, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang anak usia 3 tahun yang dirawat dengan diare, muntah, mukosa mulut kering, mata sedikit cekung, dan tampak lemas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi anak setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat	Pada kasus diare, mahasiswa menuliskan frekuensi BAB cair,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	muntah, intake cairan menurun, tanda dehidrasi, diagnosis defisit volume cairan, intervensi pemberian cairan oral, edukasi oralit, dan evaluasi perbaikan hidrasi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian cairan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus diare, mahasiswa belajar bahwa pengkajian intake-output, tanda dehidrasi, dan edukasi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep diare pada anak, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

**Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan
Keperawatan Anak dengan Diare**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus anak dengan diare, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan cairan yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau intake-output atau terlambat mengenali tanda dehidrasi, dapat berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status hidrasi, berkurangnya jumlah urin, muntah berulang, kesalahan pemberian oralit, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	dehidrasi secara berkala, mencatat intake-output dengan teliti, menjelaskan cara pemberian oralit yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada anak dengan diare, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

K. Ringkasan

Komunikasi keperawatan adalah fondasi utama dalam menjamin keselamatan pasien, khususnya pada kelompok rentan seperti anak dengan diare. Melalui penerapan teknik SBAR yang akurat saat pelaporan antar nakes, serta kemampuan Edukasi Terapeutik yang empatik kepada keluarga, perawat dapat mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan (*adverse events*). Penguasaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam komunikasi bukan sekadar pemenuhan kurikulum, melainkan investasi keselamatan bagi setiap pasien yang kita rawat.

L. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Anak sangat lemas atau tidak responsif	Menunjukkan kondisi umum memburuk, kemungkinan dehidrasi berat atau gangguan perfusi	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, lakukan pemantauan ketat, siapkan penanganan lanjutan
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan dehidrasi berat, gangguan elektrolit, atau infeksi berat	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Tidak mau minum atau tidak mampu minum	Risiko tinggi kekurangan cairan semakin berat	Segera laporkan dan evaluasi kebutuhan rehidrasi lanjutan
Muntah terus-menerus	Menghambat keberhasilan rehidrasi oral dan meningkatkan risiko dehidrasi	Laporkan segera, pantau status hidrasi, siapkan evaluasi terapi lebih lanjut
Diare sangat sering atau semakin meningkat	Menunjukkan kehilangan cairan aktif yang terus berlangsung	Laporkan, monitor intake-output dan tanda vital secara ketat
Diare berdarah	Mengarah pada kemungkinan infeksi invasif atau masalah gastrointestinal yang lebih serius	Segera eskalasi untuk evaluasi medis lebih lanjut
Mata sangat cekung, mukosa sangat kering, turgor sangat menurun	Tanda dehidrasi sedang-berat atau berat	Laporkan segera, tingkatkan kewaspadaan terhadap perburukan
BAK sangat sedikit atau tidak ada	Menunjukkan perfusi ginjal menurun dan dehidrasi memburuk	Eskalasi segera, dokumentasikan output urin

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Demam tinggi	Dapat menunjukkan infeksi yang signifikan atau komplikasi	Laporkan dan lanjutkan pemantauan ketat
Kejang	Tanda kegawatan yang dapat berkaitan dengan demam tinggi, gangguan elektrolit, atau kondisi berat lainnya	Eskalasi emergensi segera
Tanda syok: nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera	Panggil bantuan segera, laporkan emergensi sesuai alur layanan
Distensi abdomen atau nyeri perut berat	Dapat menandakan komplikasi lain di saluran cerna	Segera laporkan untuk evaluasi medis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian diare pada anak secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada anak dengan diare	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji frekuensi dan karakteristik BAB cair	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya muntah, intake cairan, dan jumlah urin	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda dehidrasi pada anak	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada anak dengan diare	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada anak dengan diare	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memantau status hidrasi dan intake-output anak	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pemberian oralit dengan benar	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menganjurkan kelanjutan ASI atau makanan sesuai toleransi anak	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada anak dengan diare kepada orang tua	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan anak dengan diare	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat anak dengan diare	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

M. Daftar Pustaka

- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses*. Elsevier.
- Kourkouta, L., & Papathanasiou, I. V. (2014). Communication in nursing practice. *Materia Socio-Medica*, 26(1), 65–67.
- Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. In *Academic Medicine* (Vol. 65).
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2011). Professional Communication and Team Collaboration. *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses*.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik*. DPP PPNI.
- Stewart, K. R., & Hand, K. A. (2017). SBAR, communication, and patient safety: An integrated literature review. *MEDSURG Nursing*, 26(5), 297–305.
- WHO. (2005). *The treatment of diarrhoea: A manual for physicians and other senior health workers*. World Health Organization.

BAB 2

KETERAMPILAN WAWANCARA KEPERAWATAN: ANAMNESIS, ACTIVE LISTENING, DAN EMPATI

Capaian Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan peran dan tujuan komunikasi keperawatan dalam membangun hubungan profesional dengan pasien dan keluarga.
- Menjelaskan keterkaitan komunikasi efektif dengan keselamatan pasien, kejadian tidak diinginkan, dan mutu layanan.
- Mengidentifikasi peran perawat sebagai komunikator klinis dalam continuum of care, termasuk koordinasi tim dan pelaporan insiden keselamatan.

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar komunikasi keperawatan, etika komunikasi profesional, dan dampaknya terhadap keselamatan pasien.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu membangun hubungan terapeutik dan melakukan wawancara/pengkajian komunikasi secara empatik, terstruktur, dan berpusat pada pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu menerapkan komunikasi nonverbal, validasi pesan, dan strategi menghadapi hambatan komunikasi untuk meningkatkan kualitas asuhan.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi interprofesional, kolaborasi, dan handover terstruktur untuk kesinambungan layanan yang aman.	CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Mampu berkomunikasi efektif pada situasi sulit/krisis serta populasi khusus dengan mempertimbangkan budaya, spiritual, dan keselamatan.	CPMK-5; CPMK-6

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-6	Mampu mendokumentasikan komunikasi klinis, memahami aspek legal, melakukan refleksi profesional, dan perbaikan praktik komunikasi berbasis evaluasi.	CPMK-7; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran, tujuan, dan prinsip komunikasi keperawatan serta keterkaitannya dengan keselamatan pasien dan profesionalisme.
CPMK-2	Menerapkan konsep proses komunikasi, etika komunikasi profesional, identifikasi hambatan, dan strategi perbaikan komunikasi.
CPMK-3	Menerapkan komunikasi terapeutik dan membangun hubungan perawat-klien sesuai fase, teknik, dan batas profesional.
CPMK-4	Melaksanakan wawancara/pengkajian komunikasi (anamnesis) dengan active listening, empati, dan pertanyaan terstruktur.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi nonverbal, validasi pesan, dan strategi komunikasi pada situasi sulit serta populasi khusus secara aman.
CPMK-6	Menerapkan komunikasi interprofesional, kolaborasi tim, negosiasi, dan eskalasi untuk koordinasi layanan yang efektif.
CPMK-7	Melaksanakan handover terstruktur (SBAR, read-back, closed-loop), dokumentasi sebagai komunikasi klinis, serta refleksi untuk perbaikan praktik.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Komunikasi Keperawatan: Peran, Tujuan, dan Dampaknya pada Keselamatan Pasien	1.1 Menjelaskan hubungan komunikasi efektif dengan kejadian keselamatan pasien dan mutu layanan.	1.2 Mengidentifikasi peran perawat sebagai komunikator klinis dalam continuum of care.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Konsep Dasar Komunikasi: Proses, Hambatan, dan Etika Komunikasi Profesional	2.1 Memetakan proses komunikasi (pengirim–pesan–kanal–penerima–umpan balik) dan titik rawan miskomunikasi.	2.2 Menerapkan etika komunikasi profesional (respek, kerahasiaan, kejujuran) pada skenario layanan.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-7
Bab 3. Komunikasi Terapeutik dan Hubungan Perawat–Klien (Fase & Teknik)	3.1 Menerapkan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase orientasi–kerja–terminasi.	3.2 Menunjukkan batas profesional dan kontrak terapeutik yang aman pada skenario.	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-5
Bab 4. Keterampilan Wawancara Keperawatan: Anamnesis, Active Listening, dan Empati	4.1 Melaksanakan anamnesis terstruktur untuk menggali keluhan utama dan riwayat relevan.	4.2 Menerapkan active listening (parafrase, klarifikasi, rangkum) dan empati yang terukur melalui respons verbal.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-5
Bab 5. Komunikasi Nonverbal dan Validasi Pesan dalam Asuhan Keperawatan	5.1 Mengidentifikasi sinyal nonverbal dan ketidaksesuaian pesan (incongruence) pada interaksi.	5.2 Melaksanakan validasi pesan (checking, teach-back sederhana) untuk memastikan pemahaman pasien.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-2
Bab 6. Komunikasi Interprofesional dan Kolaborasi Tim Kesehatan	6.1 Menerapkan prinsip kolaborasi tim (tujuan bersama, peran, respek) pada skenario koordinasi layanan.	6.2 Menyampaikan informasi klinis ringkas dan relevan kepada tim sesuai kebutuhan keputusan.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-1
Bab 7. Handover Klinis dan Komunikasi Terstruktur: SBAR,	7.1 Menyusun handover SBAR yang lengkap, ringkas, dan fokus risiko.	7.2 Menerapkan read-back/closed-loop untuk konfirmasi	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-1

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Read-back, Closed-loop		instruksi dan pencegahan error.		
Bab 8. Komunikasi dalam Situasi Sulit: Marah, Cemas, Menolak Tindakan, dan Agitasi	8.1 Mengidentifikasi pemicu emosi dan kebutuhan pasien pada situasi sulit untuk menentukan strategi respons.	8.2 Melaksanakan de-eskalasi verbal dan negosiasi tindakan dengan menjaga keselamatan dan batas profesional.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-3
Bab 9. Komunikasi dengan Keluarga dan Caregiver: Edukasi, Konseling, dan Negosiasi	9.1 Menilai kebutuhan informasi keluarga/caregiver dan menyusun tujuan edukasi yang jelas.	9.2 Melaksanakan konseling/negosiasi rencana perawatan dengan indikator pemahaman (teach-back).	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7
Bab 10. Komunikasi pada Populasi Khusus: Anak, Lansia, Gangguan Jiwa, dan Disabilitas	10.1 Menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan perkembangan, kognisi, dan kebutuhan aksesibilitas.	10.2 Menerapkan komunikasi aman pada kondisi perilaku/psikologis khusus dengan fokus keselamatan.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-6
Bab 11. Komunikasi Budaya dan Spiritual: Transkultural, Bahasa, dan Sensitivitas Nilai	11.1 Mengidentifikasi faktor budaya–bahasa yang memengaruhi pemahaman dan keputusan pasien.	11.2 Menerapkan komunikasi sensitif nilai/spiritual dan menghindari bias dalam interaksi layanan.	CPMK-2	CPMK-5; CPMK-6
Bab 12. Komunikasi dalam Kedaruratan dan Krisis: Kabar Sulit, Konflik, dan Eskalasi	12.1 Menyampaikan kabar sulit secara terstruktur dan empatik sesuai prioritas keselamatan.	12.2 Melaksanakan eskalasi konflik/krisis kepada pihak terkait dengan pesan ringkas dan fokus risiko.	CPMK-6	CPMK-7; CPMK-5

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 13. Dokumentasi Keperawatan sebagai Komunikasi Klinis dan Aspek Legal	13.1 Menyusun dokumentasi komunikatif (objektif, kronologis, relevan) untuk kesinambungan layanan.	13.2 Mengidentifikasi risiko legal dari dokumentasi tidak lengkap dan menetapkan praktik koreksi yang benar.	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-1
Bab 14. Simulasi Kasus, OSCE Komunikasi, dan Refleksi Praktik Profesional	14.1 Melaksanakan komunikasi terintegrasi (wawancara–situasi sulit–handover) pada simulasi kasus.	14.2 Menyusun refleksi kinerja komunikasi berbasis umpan balik dan rencana perbaikan terukur.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-5

A. Konsep Keterampilan Wawancara Keperawatan

Wawancara antara pasien dan perawat sangat penting, merupakan alat dalam membangun dan memelihara hubungan terapeutik. Wawancara berpusat pada pasien/klien yang dilakukan dengan tujuan melakukan interaksi, proses interaksi dijalankan dengan membina hubungan timbal balik dan terfokus pada pasien (Centikaya, 2025).

Wawancara bertujuan mengembangkan hubungan terapeutik dengan pasien, untuk mengidentifikasi bagaimana pasien memandang masalahnya dan dampaknya terhadap kehidupannya, untuk mendiagnosis stresor, untuk menentukan kebutuhan dan prioritas, dan untuk mengungkapkan motivasi dan emosi yang mendasari perilakunya. Oleh karena itu, kualitas wawancara merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kolaborasi terapeutik dan mendapatkan informasi yang tepat untuk memandu diagnosis keperawatan, manajemen perawatan, dan perawatan pasien

Wawancara yang dilakukan perawat menjadi efektif apabila keterampilan komunikasi perawat digunakan secara efektif. Efektivitas komunikasi penting dalam membangun kepercayaan antara perawat dan pasien, menciptakan hubungan terapeutik, dan memberdayakan pasien untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka dengan nyaman, membantu pasien mengelola stress dan mendukung kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perawatan yang dijalani (Centikaya, 2025).

Setiap individu adalah unik. Individu memiliki pikiran, perasaan, pengalaman, latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini melatarbelakangi respons individu terhadap permasalahan yang dihadapi, respon dan cara mengatasinya atau sebaliknya. Beberapa individu ada yang dapat mengekspresikan masalahnya, namun ada juga yang tidak, bergantung kepada coping yang dimiliki serta keberadaan sistem yang mendukung. Oleh karenanya diperlukan keterampilan komunikasi dari perawat agar pasien dapat mengutarakan masalah dan keluhannya dengan baik (Suryani, 2017).

Dalam proses wawancara hendaknya perawat menunjukkan sikap sportif dan tidak menghakimi, mengamati bagaimana pasien dapat mengekspresikan diri dengan lebih nyaman, membiarkan pasien mengungkapkan perasaan dan pikirannya, dan mendukung pasien sesuai dengan tahapan wawancara.

Keterampilan wawancara merupakan sebuah keterampilan yang harus dilatih tidak diperoleh secara instan atau dari lahir, keterampilan wawancara harus terus dikembangkan. Wawancara antara perawat dan pasien merupakan hal penting,

sebagai alat dalam membangun dan memelihara hubungan terapeutik (Sam Slade, 2023)

Keterampilan wawancara klinis merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan yang mencakup kemampuan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, observasi, active listening, dan empati. Seorang perawat tidak hanya dituntut mampu mengajukan pertanyaan, tetapi juga mampu memahami makna di balik respons pasien, menginterpretasikan informasi secara tepat, serta menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Tanpa dasar pengetahuan dan keterampilan komunikasi yang kuat, proses wawancara dapat kehilangan arah sehingga informasi yang diperoleh menjadi kurang bermakna dan tidak seluruhnya relevan terhadap kebutuhan asuhan keperawatan (Centikaya, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perawat yang mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi terapeutik dengan pasien. Di sisi lain, pasien juga sering merasakan hubungan komunikasi yang kurang efektif dengan perawat. Kondisi ini terjadi karena sebagian perawat lebih berfokus pada pekerjaan rutin dan tugas-tugas teknis dibandingkan membangun dialog terapeutik melalui pendekatan komunikasi yang efektif. Akibatnya, hubungan saling percaya antara perawat dan pasien menjadi kurang optimal dan dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan keperawatan.

Kemampuan komunikasi yang efektif sangat penting dalam membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kepuasan pasien, serta membantu perawat memahami kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan emosional pasien secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, mahasiswa keperawatan perlu mengembangkan keterampilan active listening, empati, komunikasi nonverbal, dan kemampuan observasi sejak dini agar mampu memberikan asuhan keperawatan yang holistik, manusiawi, dan berpusat pada pasien (patient centered care) (Grimm, 2015).

Penting sekali memberikan pengetahuan tentang keterampilan melakukan wawancara pada mahasiswa keperawatan, agar memiliki kompetensi keterampilan komunikasi dan wawancara yang efektif, diperlukan sebuah alat ukur yang valid dan reliabel yang akan membantu mengevaluasi keterampilan wawancara perawat. Keterampilan ini harus diukur dengan cara yang konsisten, stabil, dapat diulang, dapat diterapkan dan dapat dipahami.

Keterampilan wawancara perlu dilatih, hasil penelitian (Centikaya, 2025) yang melakukan pelatihan kepada mahasiswa keperawatan di Turki yang sedang magang, telah mendapatkan mata kuliah Keterampilan Komunikasi Dasar di tahun pertama dan mata kuliah keterampilan komunikasi dalam keperawatan di tahun kedua, mahasiswa dilakukan pelatihan wawancara dan mempraktikkan wawancara dengan

sebuah skenario melakukan wawancara kepada pasien dengan skenario, dan dilakukan pengamatan selama 4 minggu pelaksanaan wawancara. Proses wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa perawat dinilai dan diamati menggunakan daftar periksa penilaian keterampilan wawancara. Penelitian tersebut berhasil menjelaskan penilaian keterampilan wawancara dengan melakukan observasi terhadap penerapan keterampilan wawancara mahasiswa keperawatan, yang dapat diadopsi bagi mahasiswa saat ingin menerapkan keterampilan wawancara yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

Faktor	Tehnik dan Langkah-langkah wawancara
Manajemen Wawancara	Menata lingkungan pertemuan dengan tepat
	Gunakan Bahasa tubuh yang tepat selama wawancara (menjaga kontak mata, menoleh ke lawan bicara, intonasi suara, dan lain-lain)
	Menanyakan kepada pasien apa yang ingin ditambahkan tentang topik wawancara
Menyusun kerangka wawancara	Menjelaskan tujuan wawancara
	Menjelaskan dengan siapa data percakapan dapat dibagikan
	Merangkum isi wawancara
Keterampilan Komunikasi	Menyampaikan tujuan wawancara
	Mengungkapkan perasaan dan pemikiran inidividu
	Menggunakan tehnik bertanya yang tepat sesuai dengan alur percakapan (pertanyaan terbuka dan tertutup)
	Meningkatkan kejelasan ekspresi yang samar namun terlihat
	Menggunakan pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mendengarkan secara aktif (Hmmm, oke, lanjutkan, dll)
	Menggunakan ungkapan empati terkait perasaan dan pikiran pasien
	Sepanjang wawancara menggunakan kata-kata lisan yang dapat dipahami pasien
	Lakukan wawancara sesuai dengan tujuan pertemuan

Sumber: Penelitian Cetinkaya at all (2025)

Keterampilan wawancara dibentuk dan diselesaikan melalui proses latihan, pembelajaran yang terus menerus dalam struktur dan proses tertentu. Keterampilan komunikasi dapat diperhatikan mulai dari fase identifikasi dan kerja, teknik komunikasi berfokus pada keterampilan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang efektif, menggunakan teknik komunikasi terapeutik (menunjukkan empati), menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan mempertahankan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Pada fase terminasi mencakup keterampilan seperti meringkas untuk menyimpulkan komunikasi dengan tepat (Sam Slade, 2023).

Hubungan perawat dan pasien adalah proses dinamis, dan perawat memegang berbagai peran sepanjang proses tersebut. Keterampilan wawancara yang dimiliki perawat merupakan dasar untuk memastikan hubungan terapeutik perawat dan pasien (Raphael, 2015).

B. Anamnesis

Melakukan anamnesis pada pasien harus menggunakan teknik wawancara yang tepat, pewawancara harus selalu memperhatikan suasana hati pasien, pola bicara pasien, pola bicara merupakan jendela kedalam proses berpikir pasien, misalnya kecepatan, volume dan teknik berbicara harus diperhatikan selama wawancara. Suasana hati dan pikiran pasien dapat dilihat dari pola bicara, misalnya bicara yang lambat dengan isi yang tidak berkualitas sering ditemukan pada pasien yang depresi, bicara yang tertekan dan menyimpang sering ditemukan pada mania (Grimm, 2015). Dalam teknik anamnesis pada beberapa pasien dengan kasus kejiwaan tidak selalu menggambarkan keberhasilan wawancara, namun penelitian membuktikan bahwa wawancara yang bijaksana dan penuh perhatian adalah cara yang efektif untuk dapat mengidentifikasi dengan tepat orang-orang yang beresiko mengalami gangguan jiwa (Buku psikologi).

Anamnese dilakukan dengan teknik mendengarkan aktif dan empati dapat membantu memberikan asuhan kepada pasien, asuhan keperawatan dalam penerapan komunikasi terapeutik, menggunakan empati dapat menimbulkan pikiran positif bagi pasien dalam menyampaikan keluhan tentang kondisinya, sehingga pasien akan cenderung terbuka kepada perawat yang dianggap mampu meresponi keluhannya dengan baik dan memahami kondisinya (Raphael, 2015)

C. Keterampilan Mendengarkan

Dalam sebuah komunikasi mendengarkan sering diartikan sebuah tindakan yang pasif, namun pada dasarnya mendengarkan adalah sebuah proses aktif dari

sebuah proses dalam menerima stimulus (rangsangan) pada organ telinga (aural). Mendengarkan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sengaja, merupakan respon dari pendengar yang memerlukan energi dan komitmen dalam menjalankan sebuah proses komunikasi interpersonal (Nikodemus Thomas Matoredjo).

Mendengar (*hearing*) dengan mendengarkan (*listening*) berbeda sekali, mendengar merupakan sebuah proses fisiologis, sementara mendengarkan menyangkut penerimaan rangsangan. Penerimaan rangsangan disini menegaskan bahwa seseorang yang mendengarkan berarti menyerap rangsangan yang diterima, selanjutnya memprosesnya dengan cara tertentu. Nikodemus mengutip pendapat Janasz (2009) yang mengemukakan dalam proses komunikasi, penerima pesan agar dapat memperoleh pesan yang utuh dari pengirim pesan, harus mendengarkan dengan menggunakan panca indera secara tepat. Oleh karenanya dalam mendengarkan secara aktif perlu memperhatikan tiga dimensi yaitu penginderaan, pengolahan, evaluasi dan memberi respon. Jadi mendengarkan adalah tindakan aktif, menjadi pendengar aktif merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam berbagai kegiatan termasuk dalam memberikan asuhan keperawatan (Martoredjo, 2014).

D. Active Listening

Mendengarkan secara aktif adalah proses komunikasi atau penyampaian informasi yang ditandai dengan pertukaran informasi, di mana satu pihak sebagai pengirim menyampaikan informasi melalui cara verbal, tertulis, atau nonverbal kepada pihak lain sebagai penerima. Penerima pesan mendengarkan secara aktif, dan sangat penting bagi penerima untuk mengakui bahwa penerimaan informasi sudah dilakukan dengan baik dan memberikan umpan balik kepada pengirim untuk memastikan pemahaman bersama. Mendengarkan aktif (juga disebut mendengarkan empatik, teknik pembicara-pendengar, mendengarkan reflektif, mendengarkan dialogis, dll.), memberikan perhatian yang paling besar. Mendengarkan aktif melibatkan pengulangan versi parafrase dari pesan pembicara, mengajukan pertanyaan bila perlu, dan mempertahankan keterlibatan percakapan nonverbal yang cukup tinggi (Tennant1, Long, & Toney-Butler., 2023)

Mendengarkan secara aktif didefinisikan oleh International Listening Assotiation (ILA; 2012) yang dikutip oleh Harry Weber (2014), adalah sebagai, "proses menerima, membangun makna dari, dan menanggapi pesan lisan dan/atau nonverbal". sementara Rogers (1951) merumuskan mendengarkan empatik sebagai teknik psikoterapi, yang menunjukkan penerimaan tanpa syarat dan refleksi tanpa bias terhadap pengalaman klien melalui parafrase pesan. Levitt (2001) mengidentifikasi mendengarkan aktif sebagai keterampilan mikro terapeutik yang

melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanggapi secara empatik sehingga klien merasa didengar (Harry Weger, 2014).

Penting untuk memperlancar dan membuat komunikasi menjadi berkualitas, yaitu sikap mendengarkan secara aktif. Dalam berkomunikasi, kita mungkin bersikap mendengar, tetapi belum mendengarkan secara aktif (Martoredjo, 2014).

Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif tidak diperoleh sejak lahir, komunikasi efektif merupakan keterampilan yang dipelajari dan membutuhkan Latihan dan penyempurnaan berkelanjutan. Kemampuan berkomunikasi secara efektif mendukung kerja tim dan membangun hubungan pasien yang kuat, yang sangat penting untuk perawatan kesehatan yang positif dan meningkatkan efektivitas pemecahan masalah dalam tim serta secara signifikan mengurangi kemungkinan kesalahan (Suryani, 2017).

Komunikasi yang jelas dilingkungan perawatan kesehatan sangat penting, namun masih banyak profesional yang meremehkan tantangan dalam menjaga komunikasi yang jelas dalam layanan kesehatan yang kompleks. Sikap yang meremehkan komunikasi efektif justru sering semakin memperparah stres di tempat kerja. Kondisi yang memerlukan komunikasi efektif dapat terjadi di ruang rawatan pasien dan ruang operasi, ruang konsultasi dan lainnya. Komunikasi yang terjadi di ruang operasi semua orang fokus pada tugas dan berupaya mencapai hasil yang positif. Respons terhadap pertanyaan dapat dipersingkat karena tekanan waktu. Komunikasi yang singkat seperti itu dapat menyebabkan salah tafsir, yang dapat meningkatkan stres tim. Oleh karena itu, meskipun waktu terbatas, berupaya mencapai kejelasan dan kelengkapan dalam komunikasi sangat penting untuk meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan.

Active listening (mendengarkan secara aktif) adalah sikap partisipatif, yang membutuhkan persiapan fisik dan mental. Posisi tubuh yang baik akan mendukung kegiatan, menengangkan dan menerima sinyal-sinyal yang disampaikan lewat komunikasi non verbal secara baik. Selain itu kesiapan mental juga memberi dorongan untuk dapat berpartisipasi dalam mendengarkan secara aktif. Sebagai pendengar, partisipasi dalam kegiatan komunikasi adalah setara dengan pembicara atau sumber informasi. Pendengar secara emosional dan intelektual harus siap untuk terlibat dalam proses berbagi makna dalam komunikasi. Namun sikap partisipatif ini bukan berarti sikap tegang dan tidak nyaman ketika mendengarkan. Tubuh tetap rileks dalam menyimak pesan yang mau disampaikan sambil menangkap pesan lewat kata-kata yang diucapkan dan bahasa tubuh yang menyertainya. Beberapa cara untuk membantu meningkatkan partisipasi dalam komunikasi adalah dengan berusaha secara maksimal untuk mendengar dengan mengaktifkan panca indera. Lawan dan hindari hal-hal yang mengganggu atau

mengintervensi komunikasi yang sedang dilakukan. Selain itu, tidak membiarkan diri untuk melamun atau membiarkan pikiran melantur jauh dari pokok pembicaraan, tetapi berusaha membangun asumsi bahwa pesan yang disampaikan mempunyai nilai dan bermanfaat (Raphael, 2015).

Mendengarkan aktif sebagai memiliki tiga bagian: 1) menunjukkan keterlibatan nonverbal dari sedang sampai tinggi, 2) mencerminkan pesan pembicara dengan menggunakan parafrase verbal, dan 3) dapat mencakup mengajukan pertanyaan yang mendorong pembicara atau komunikasi untuk menguraikan pengalamannya. Sehingga mendengarkan aktif merupakan aktivitas yang memunculkan pandangan positif dan pengalaman komunikasi yang menyenangkan, terutama pada fase awal pertemuan atau percakapan/komunikasi awal. Interaksi awal merupakan konteks penting untuk mempelajari keterampilan mendengarkan. Setiap hubungan dimulai dengan pertemuan pertama yang membutuhkan kepastian terhadap sebuah informasi yang belum diketahui, dapat menghilangkan keraguan dan ketidakpastian dalam situasi baru yang dialami seseorang. (Harry Weger, 2014).

Pendengar yang kompeten (orang yang mendengarkan secara aktif), sangat dibutuhkan dalam interaksi awal (pertemuan awal), pendengar yang kompeten dikaitkan dengan orang yang penuh perhatian, ramah, pengertian, responsif, dan mampu mengelola situasi, memahami alur percakapan. Selain itu perilaku mendengarkan juga dikaitkan dengan kemampuan melakukan paraphrase verbal yaitu perhatian terhadap lawan bicara dan daya tanggap terhadap komunikasi yang berlangsung, dan mampu mengelola pertanyaan dengan baik. Pertanyaan yang diajukan dikaitkan dengan pengelolaan percakapan yang baik, perhatian dan daya tanggap. Perilaku nonverbal seperti kontak mata dan ketenangan terkait dengan perhatian, keramahan, dan kemampuan mengelola percakapan (Harry Weger, 2014).

Dalam melakukan active listening terdapat tantangan yang akan dihadapi. Menurut Suryani (2017), ada beberapa tantangan dalam mendengarkan secara aktif. Dengan mengantisipasi tantangan tersebut, komunikasi interpersonal yang berjalan lancar dapat diciptakan dan menjadi bermakna (Suryani, 2017). Tantangan dalam mendengarkan secara aktif antara lain:

1. Keterbatasan fisiologis: mendengarkan secara aktif membutuhkan energi. Kegiatan mendengarkan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan membuat konsentrasi dan fokus semakin berkurang;
2. Latar belakang informasi yang dimiliki masih kurang memadai. Ketika seseorang kurang memahami latar belakang hal yang dibicarakan, maka sulit untuk aktif terlibat dalam komunikasi tersebut. Persiapan yang kurang memadai akan membuat penerima pesan menjadi pasif dan hanya mendengar saja tanpa memberi feedback yang memadai;

3. Sikap terhadap pembicara. Sikap sebagai kawan atau lawan bagi pembicara sering membuat kegiatan mendengarkan secara aktif menjadi bias dan ini berarti tidak bersikap netral dalam menerima pesan yang disampaikan sumber;
4. Mendengar apa yang diharapkan. Sering kali terjadi orang terkesan dengan pesan-pesan yang disampaikan pembicara. Namun, pendengar tidak mendengarkan apa yang sebenarnya mau disampaikan, malah sebaliknya, mendengar apa yang diharapkan saja;
5. Mendengarkan secara setengah-setengah dan terselingi. Hanya kata-kata saja yang didengarkan tanpa memperhatikan konteks pembicaraan itu, ekspresi yang ditampilkan, tinggi rendahnya suara atau pesan nonverbal lainnya;
6. Gangguan emosional. Meski dalam komunikasi sangat baik untuk mengekspresikan emosi, namun tidak setiap orang dapat mengerti, mengontrol, atau menjelaskan perasaan yang sesungguhnya;
7. Situasi dan keadaan sekitar. Lingkungan/tempat berkomunikasi menentukan seseorang dapat atau tidak dapat mendengarkan secara aktif. Gangguan yang cukup serius dari lingkungan akan membuat kelancaran komunikasi semakin terhambat.

Faktor-faktor diatas menjadi tantangan dalam mendengarkan secara aktif. Karena itu perlu strategi dan persiapan yang cukup sebagai latar dalam berkomunikasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pentingnya mendengarkan secara aktif karena dapat memperlihatkan kepada pembicara atau pengirim pesan bahwa lawan bicaranya benar-benar terlibat dalam komunikasi tersebut. Selain itu, dengan perhatian penuh kepada pembicara, pendengar yang aktif dapat lebih fokus pada inti dari pesan yang disampaikan dan memberi umpan balik berupa tanggapan atau pertanyaan agar pendengar lebih memahami tentang apa yang dibicarakan. Dengan demikian komunikasi transaksional telah terjadi.

Umpan balik dalam berbagai bentuk dapat menjadi bagian penting untuk komunikasi lebih jauh. Dalam mendengarkan secara pasif, komunikasi yang terjadi hanya ada satu arah. Sementara dalam komunikasi dengan mendengarkan secara aktif, kedua pihak saling menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadi pertukaran ide atau pesan dengan baik sehingga dapat meningkatkan relasi yang ada. Dalam mendengarkan secara aktif, terjadi situasi saling mendukung dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat. Di sana terjadi saling menguatkan dan saling percaya antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam menyampaikan umpan balik setidaknya harus

Mendengarkan secara aktif dapat mengurangi banyak sekali kesalahan persepsi dan meningkatkan pengalaman komunikasi interpersonal yang hangat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan active listening meningkatkan ikatan emosional dan pengalaman asuhan keperawatan pada semua kelompok usia termasuk pengalaman pengasuhan pada anak-anak (Ruth Irmgard Bärtschi Gabatz, 2018)

Penelitian lainnya yang melakukan penelitian tentang efektivitas mendengarkan secara aktif dalam interaksi awal menunjukkan hasil bahwa partisipan yang menerima respons mendengarkan aktif merasa lebih dipahami daripada partisipan yang menerima nasihat atau pengakuan sederhana. Lebih lanjut, partisipan yang menerima respons mendengarkan aktif atau nasihat lebih puas dengan percakapan mereka dan menganggap rekan yang dapat mendengarkan mereka secara aktif lebih menarik (Harry Weger, 2014).

E. Empati

Mendengarkan secara Empati Berempati berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Hanya dengan empati seseorang dapat memahami maksud sepenuhnya dari orang lain. Mendengar secara empati berarti melibatkan tidak hanya pikiran saja melainkan juga menempatkan perasaan secara proporsional dalam komunikasi tersebut. Dalam mendengarkan secara empati harus diingat bagaimana sudut pandang dari mitra komunikasi. Mencoba menyelami pikiran dan perasaan merupakan langkah yang baik dalam mendengarkan secara aktif. Untuk mendorong keterbukaan dan empati, setiap penghambat fisik dan psikologis atas kesetaraan harus dihilangkan dan dihindari misalnya dengan tidak memotong pembicaraan atau juga menjaga jarak fisik dengan lawan bicara.

Mendengarkan tanpa menilai namun kritis adalah mendengarkan dengan mengedepankan pikiran yang terbuka dan berusaha memahami setiap makna dari pesan yang disampaikan sehingga tidak melakukan penilaian sebelum mendengarkan sepenuhnya. Ini tidak mudah, terutama jika berhadapan dengan pernyataan yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan. Hal ini membuat mendengarkan dalam situasi yang tidak mudah menjadi penting. Mendengarkan perlu dilakukan dengan sikap kritis untuk menciptakan komunikasi yang bermakna. Mendengarkan secara terbuka akan sangat baik dalam memahami pesan yang mau disampaikan, sementara sikap kritis dapat membantu dalam menganalisis dan mengevaluasi pesan tersebut. Dalam hal ini perlu untuk menyadari bias yang dapat terjadi dalam menangkap pesan. Bias-bias itu dapat mengganggu tindakan

mendengarkan secara aktif dalam merespons secara akurat. Bias tersebut dapat menyebabkan distorsi dari makna sebenarnya. (Marijan Tustonja, 2023)

Mendengar secara mendalam dapat memahami makna yang jelas dan dapat ditangkap secara harfiah makna yang terkandung dari pesan yang disampaikan tersebut. Walau demikian, tidak jarang terdapat tingkat makna yang lain dan terkadang makna itu bertentangan dengan makna harafiah atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Ketika mendengarkan secara mendalam seseorang harus peka dengan berbagai tingkat makna. Jika hanya coba memahami makna tingkat permukaan, maka akan kehilangan kesempatan untuk membuat kontak lebih mendalam dan menyadari sepenuhnya dari makna pesan yang mau disampaikan. Oleh karena itu perlu untuk memusatkan perhatian terutama pada pesan-pesan nonverbal yang mengikuti pesan verbal. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada keraguan di dalamnya (Harry Weger, 2014).

Empati dari perawat perlu dikembangkan dan ditingkatkan, karena area pelayanan perawat pada lingkup rumah sakit adalah memberikan pelayanan pada orang yang sakit, yang secara psikologis mengalami kecemasan atau kekhawatiran dengan kondisi mereka atas penyakit yang dialami. Oleh karenanya perlu dipandang pengembangan rasa empati sebagai sikap atau tindakan yang penting untuk dipahami dan diterapkan perawat dalam memberikan asuhan (Suryani, 2017).

Dari perspektif pasien, kompetensi klinisi bukan hanya tentang menunjukkan pengetahuan mendalam tentang anatomi dan fisiologi atau tindakan perawatan yang diberikan dalam pemenuhan kebutuhan pasien, tetapi lebih tentang mengekspresikan belas kasih dan menerjemahkan informasi medis dengan cara yang memberikan tingkat pemahaman terbaik (Raphael, 2015).

Komunikasi yang dilakukan perawat pada saat anamneses perlu dilakukan dengan menerapkan keterampilan wawancara dengan tehnik mendengarkan aktif dan empati. Pasien sebagai penerima layanan akan memberikan apresiasi kepada perawat sebagai pemberi asuhan apabila dirasakan melakukan layanan dengan penuh empati. Pasien yang percaya bahwa penyedia layanan kesehatan mereka suportif, terlibat, dan berempati akan jauh lebih puas dengan perawatan mereka. Bahkan dalam situasi di mana pasien percaya bahwa perawatan mereka tidak memadai atau bahkan berbahaya, mereka cenderung tidak akan melakukan tindakan hukum jika mereka juga percaya bahwa penyedia layanan kesehatan mereka peduli kepada mereka, bertindak dengan itikad baik, dan mengutamakan kepentingan terbaik mereka. Menjalin hubungan dengan pasien, sebagai mitra dalam perawatan mereka, dengan tujuan mencapai hasil kesehatan terbaik, menunjukkan kesediaan untuk memberikan layanan terbaik, penuh perhatian dan mendukung pasien, menimbulkan kekuatan bagi pasien. Kekuatan dari pertemuan

positif memberikan kenyamanan bagi pasien dan rasa makna serta tujuan bagi praktisi, karena telah berbagi momen-momen penting dalam hidup pasien dengan cara yang secara positif memengaruhi pengalaman pasien, bahkan selama transisi pasien menuju kematian. Pertemuan positif bermanfaat bagi semua orang. Tantangannya terletak pada menciptakannya secara sadar, konsisten, dan efisien waktu, bahkan dalam situasi yang tampaknya penuh dengan hambatan interpersonal. Hal ini membutuhkan kesadaran penuh, upaya yang komunikasi terapeutik yang berarti bagi pasien, empatik, bermakna dan positif (Grimm, 2015)

F. Aktivitas 1: Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh Kasus:

Seorang pasien laki-laki, Tn. A, usia 45 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan utama sesak napas sejak 2 hari terakhir. Pasien tampak gelisah, sering menarik napas dalam, dan berbicara dengan kalimat-kalimat pendek.

Saat perawat mencoba mengajukan pertanyaan, pasien terlihat kurang fokus dan menjawab singkat. Istri pasien yang mendampingi terlihat lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dibandingkan dengan pasien.

Dari observasi awal, pasien tampak cemas dan beberapa kali memegang dada. Riwayat penyakit sebelumnya belum tergal dengan jelas. Pasien baru masuk ruang IGD. Komunikasi belum terjalin secara efektif.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk melakukan anamnesis lebih lanjut terhadap Tn. A, dengan kasus di atas.

Pertanyaan diskusi:

1. Apa hambatan komunikasi yang muncul pada kasus Tn. A di atas?
2. Data apa saja yang belum tergal secara optimal?
3. Langkah-langkah wawancara yang dapat dilakukan perawat terhadap Tn A. Agar keluhan utama dan riwayat relevan dapat diketahui secara lengkap?
4. Bagaimana strategi perawat untuk membangun komunikasi yang efektif?
5. Teknik komunikasi apa yang paling tepat digunakan pada kondisi pasien tersebut di atas?

Diskusikan jawaban bersama kelompok.

G. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab

Mempraktikkan Keterampilan Wawancara Keperawatan

Langkah-langkah Teknik Wawancara Keperawatan

1. Tahap Persiapan (*Pre-interaction Phase*)

- a. Mempelajari data awal pasien
- b. Menyiapkan lingkungan yang nyaman dan privasi terjaga
- c. Menyiapkan diri (penampilan rapi, sikap tenang)

2. Tahap Orientasi (*Perkenalan*)

Tujuan: membangun hubungan saling percaya

Contoh:

- "Selamat pagi Pak, saya perawat yang akan membantu Bapak hari ini."
- Verifikasi identitas pasien
- Jelaskan tujuan wawancara
- Ciptakan suasana nyaman

Teknik yang digunakan:

- Kontak mata
- Senyum terapeutik
- Nada suara tenang

3. Tahap Kerja (*Working Phase / Anamnesis*)

Tujuan: menggali informasi secara lengkap

a. Menggali Keluhan Utama

Gunakan pertanyaan terbuka, misalnya: "Apa yang Bapak rasakan saat ini?"

b. Eksplorasi Riwayat Penyakit

- Onset: sejak kapan
- Durasi: berapa lama
- Karakter: seperti apa rasanya
- Faktor pencetus/peringatan

c. Teknik Active Listening

- Mengangguk
- Memberi respon singkat ("ya", "baik")
- Mengulang pernyataan pasien: "Jadi sesaknya semakin berat sejak kemarin, ya Pak?"

d. Menunjukkan Empati

- "Saya mengerti Bapak merasa tidak nyaman dengan kondisi ini."
- "Wajar jika Bapak merasa cemas."

e. Klarifikasi dan Validasi

- "Apakah benar nyeri terasa seperti tertindih di dada?"

4. Tahap Terminasi (*Penutup*)

- Menyimpulkan hasil wawancara
- Memberikan kesempatan bertanya
- Menjelaskan langkah selanjutnya

Contoh:

- “Baik Pak, dari hasil wawancara tadi...”
- “Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan?”

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

5. Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	Keterampilan Wawancara Keperawatan

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

6. OSCE Ringkas + Critical Items

a. Critical Items (WAJIB LULUS)

- Verifikasi identitas pasien
- Menjelaskan tujuan wawancara
- Menggali keluhan utama pasien dan riwayat relevan
- Penggunaan pertanyaan terbuka dilakukan secara benar
- Pertanyaan yang diajukan terstruktur
- Menerapkan empati yang terukur melalui respons verbal
- Melakukan active listening
- Melakukan klarifikasi/validasi data penting
- Menyimpulkan hasil wawancara
- Sikap profesional
- Eskalasi bila red flags muncul

b. Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keterampilan wawancara	Dilakukan dengan benar dan lengkap	Dilakukan tetapi kurang tepat/kurang lengkap	Risiko kecil	Tidak aman
Pembukaan wawancara	Salam, pengenalan diri, verifikasi	Memberikan salam namun tidak lengkap	Memberikan salam namun	Tidak memberikan

Kriteria	4	3	2	1
	identitas dilakukan dengan lengkap		tidak berurutan dan tidak jelas	an salam /tidak mem perke nalka n diri
Penjelasan tujuan wawancara/anamnesis	Menjelaskan tujuan wawancara secara lengkap dan jelas	Menjelaskan tujuan wawancara namun terburu-buru	Menjelaska n tujuan namun tidak lengkap	Tidak menj elask an tujua n wawa ncara
Penggunaan pertanyaan terbuka	Konsisten menggunakan pertanyaan terbuka yang relevan dan efektif	Menggunaka n pertanyaan terbuka tetapi terbatas	Mengguna kan pertanyaan terbuka tetapi kurang tepat	Tidak meng guna kan perta nyaan terbu ka
Penggalian keluhan utama	Menggali keluhan utama secara sistematis, runut dan lengkap	Menggali keluhan utama tetapi tidak sistematis	Menggali keluhan utama tetapi tidak lengkap	Tidak meng gali keluh an utam a
Active listening dipraktikan kepada pasien	Dilakukan dengan benar dan tepat (Kontak mata, respon verbal/non verbal, dan fokus	Dilakukan dengan menunjukkan perhatian tetapi tidak konsisten	Dilakukan tapi tidak tepat	Tidak dilak ukan

Kriteria	4	3	2	1
	pada pasien secara konsisten)			
Kemampuan dalam sikap empati	Menunjukkan empati dengan tepat, menunjukkan dukungan penuh dan sesuai kondisi pasien	Menunjukkan empati tetapi kurang tepat	Menunjukkan empati namun kurang tepat	Tidak dilakukan
Klarifikasi dan Validasi	Klarifikasi dan validasi dilakukan dengan jelas dan membantu pasien memahami kondisi	Klarifikasi dan validasi dilakukan namun kurang tepat	Klarifikasi dan validasi dilakukan namun tidak tepat	Tidak dilakukan
Sikap Profesional	Menunjukkan sikap sopan, menghargai dan profesional sepanjang wawancara	Menunjukkan sikap cukup sopan tetapi kurang konsisten	Menunjukkan sikap cukup sopan namun tidak tepat	Menunjukkan sikap tidak profesional (tidak sopan dan kurang menghargai)
Asesmen & Rangkuman	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Penutup wawancara	Menyimpulkan hasil dan menutup dengan baik	Menutup namun kesimpulan	Menutup tetapi tanpa	Tidak menutup

Kriteria	4	3	2	1
		kurang lengkap	kesimpulan	wawancara

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi wawancara langsung dapat dilakukan dengan terstruktur, keluhan dapat digali

H. Soal Osce Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Wawancara Keperawatan: Anamnesisi, Active Listening dan Penggalan riwayat relevan
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan wawancara keperawatan melalui penerapan active listening (parafrase, klarifikasi, rangkum) dan empati yang terukur melalui respons verbal serta menggali riwayat kesehatan relevan
5	Kompetensi	1. Keterampilan melakukan wawancara/anamnesis 2. Kemampuan dalam komunikasi keperawatan 3. Kemampuan menerapkan komunikasi terapeutik 4. <i>Active listening</i> 5. Empati 6. Teknik bertanya secara sistematis dan terukur 7. Mampu menggali riwayat kesehatan pasien 8. Kemampuan membuat kesimpulan dan rangkuman
6	Kategori	1. Wawancara terstruktur 2. Mengetahui dengan jelas riwayat penyakit 3. Riwayat kesehatan relevan 4. Menunjukkan active listening 5. Memperlihatkan sikap empati 6. Melakukan validasi data

No.	Komponen	Isi
		7. Menggali keluhan utama pasien (menggunakan tehnik probing) 8. Menyimpulkan hasil wawancara 9. Menutup wawancara dengan baik
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki, Tn. A, usia 45 tahun, datang ke Rumah Sakit dengan keluhan utama sesak napas sejak 2 hari terakhir. Pasien tampak gelisah, sering menarik napas dalam, dan berbicara dengan kalimat pendek. Pasien tampak cemas dan beberapa kali memegang dada. Riwayat penyakit sebelumnya belum tergal dengan jelas, pasien baru masuk ruang IGD, komunikasi belum terjalin efektif. TUGAS: 1. Lakukan wawancara keperawatan pada pasien untuk menggali informasi terkait keluhan yang dialami dengan menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang tepat. 2. Tuliskan keluhan utama pasien dan riwayat relevan dari data yang disampaikan pasien berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan riwayat kesehatan yang relevan 4. Lakukan strategi komunikasi yang efektif pada kasus diatas 5. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 6. Lakukan rangkuman hasil anamnese secara terstruktur dan sistematis
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki, Tn. A, usia 45 tahun, datang ke Rumah Sakit dengan keluhan utama sesak napas sejak 2 hari terakhir. Pasien tampak gelisah, sering menarik napas dalam, dan berbicara dengan kalimat pendek. Pasien tampak cemas dan beberapa kali memegang dada. Riwayat penyakit sebelumnya belum tergal dengan jelas, pasien baru masuk ruang IGD, komunikasi belum terjalin efektif. TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada Tn A pada kasus diatas. 2. Tuliskan strategi komunikasi efektif yang dapat diterapkan pada kasus skenario diatas 3. Tuliskan pertanyaan terstruktur yang dapat digunakan peserta ujian dalam melakukan anamnesis 4. Lakukan observasi keterampilan komunikasi mahasiswa 5. Melakukan penilaian menggunakan daftar check list dan rubrik INSTRUKSI PENGUJI: 2. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan salam pembukaan; meliputi salam, perkenalan diri, dan verifikasi identitas pasien 3. Menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tujuan wawancara/anamnesis, meliputi: peserta ujian menyampaikan tujuan anamnesis dengan jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami 4. Menilai kemampuan peserta dalam menggunakan pertanyaan terbuka, meliputi; konsisten dalam melakukan anamnesis dan menggali keluhan yang dirasakan pasien dengan relevan dan efektif 5. Menilai kemampuan peserta dalam menggali keluhan utama secara sistematis, runut dan lengkap 6. Menilai kemampuan peserta dalam menerapkan <i>active listening</i> saat wawancaa/anamnesisi, meliputi; kontak mata, respon verbal/nonverbal, dan fokus pada pasien secara konsisten 7. Menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan empati kepada pasien dengan tepat, tulus dan sesuai kondisi pasien 8. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan klarifikasi dan validasai secara jelas dan membantu pemahaman pada pasien tentang kondisinya 9. Menilai kemampuan peserta dalam menggali keluhan utama dan riwayat kesehatan relevan

No.	Komponen	Isi
		10. Menilai kemampuan peserta ujian dalam menggunakan pertanyaan terstruktur, efektif dan relevan 11. Menilai kemampuan peserta melakukan anamnesis secara keseluruhan 12. Menilai kemampuan peserta dalam menyimpulkan hasil anamnesis dan menutup wawancara dengan baik 13. Menilai sikap profesional peserta ujian, meliputi; kesopanan, menghargai dan profesional sepanjang wawancara.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: Tn A 45 Tahun 2. Keluhan utama: Sesak napas sejak 2 hari terakhir. 3. Rawat penyakit saat ini: sesak muncul saat melakukan aktivitas, disertai rasa berat di dada, tidak ada demam 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial dan aktivitas: Tn A merokok sudah lebih dari 15 tahun, sebelumnya pernah mengalami keluhan serupa, yaitu sesak napas, dan berkurang karena berobat ke dokter. 6. Ekspresi dan Perilaku: Tn A tampak cemas, bicara pendek-pendek dan sedikit tersengal-sengal, terlihat cuping hidung, dada naik turun, dan sulit fokus 7. Respon yang diharapkan: Menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan peserta ujian, tidak memberikan informasi jika tidak ditanyakan, menunjukkan kecemasan ringan. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Simulasi/Ruang Rawat Jalan: - Tempat tidur pasien - 1 Meja, dan 2 Kursi - TM berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji

No.	Komponen	Isi
		Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Meja dan Kursi 3. Kursi TM 4. Meja penguji 5. Kursi penguji 6. Pintu masuk 7. Troli alat 8. Tabung oksigen lengkap 9. Wastafel/handrub 10. Tempat sampah 11. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Alat pengukur Tanda-Tanda Vital (Tensi meter, temperature, Stetoscope) 5. Nier Beken 6. Stopwatch/jam 7. Catatan 8. Lembar jawaban peserta 9. Lembar Penilaian Penguji Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Erna Juliana Simatupang
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI KETERAMPILAN WAWANCARA KEPERAWATAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan lingkungan yang nyaman dan privasi terjaga				
3	Menyiapkan diri (rapi) dan sikap tenang				
4	Menyiapkan peralatan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub/hand sanitizer c. Tissue d. Alat pengukur tanda-tanda Vital (Tensi meter, temperature, Stetoscope) e. Nier Beken f. Stopwatch/jam g. Catatan h. Lembar jawaban peserta i. Lembar Penilaian Penguji j.				
5	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
6	Menyampaikan salam terapeutik				
7	Menyampaikan nama dan peran perawat				
8	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
9	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
10	Memberi kesempatan bertanya				
11	Memulai tindakan dengan baik				
12	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 13 s.d. 28: sistematis)				
13	Melakukan hand hygiene				
14	Menggunakan sarung tangan bersih (pasien mengalami sesak)				
15	Melakukan anamnesis				
16	Menggali keluhan utama pasien: menggunakan pertanyaan terbuka dan terstruktur: "Apa yang Bapak rasakan saat ini?"				
17	Eksplorasi riwayat penyakit: sejak kapan (onset), berapa lama (durasi), seperti apa dirasakan (karakter), dan faktor pencetus/memperingan kondisi atau keluhan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
18	Mendengarkan dan merepson pasien menggunakan tehnik Active Listening (mengganggu, memberi respon singkat: ya/tidak, mengulang pernyataan pasien, fokus pada pasien dan menjaga kontak mata dengan sopan kepada pasien saat berkomunikasi)				
19	Menunjukkan sikap empati selama wawancara berlangsung				
20	Melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil wawancara yang dilakukan: Apakah benar sesak yang bapak rasakan dimulai dari 2 hari yang lalu dan dada ada rasa nyeri di dada? dan seterusnya...				
21	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
22	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
23	Menyimpulkan hasil wawancara				
24	Memberikan kesempatan bertanya				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
25	Memberikan reinforcement positif				
26	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
27	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
28	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan wawancara dan rangkuman serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
29	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsive				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: Keterampilan Wawancara
Keperawatan: Anamnesis, Active Listening, dan Empati

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Keterampilan Wawancara	Menata lingkungan pertemuan dengan tepat, menggunakan bahasa tubuh yang tepat selama wawancara (menjaga kontak mata, menoleh ke arah pasien saat pasien menyampaikan informasi, intonasi suara, dll)					1	
2	Menyusun pertanyaan terstruktur sesuai kondisi pasien	Menanyakan pada pasien topik yang ingin ditambahkan dalam wawancara, menjelaskan tujuan wawancara, menjelaskan dengan siapa data wawancara dapat dibagikan, diakhir wawancara meminta pasien merangkum isi wawancara, dan perawat merangkum isi wawancara diakhir wawancara					2	
3	Implementasi keterampilan wawancara	Menggali pengalaman pasien: eksplorasi lebih dalam pengalaman pasien, Melakukan observasi dan pengamatan terhadap perubahan positif dan negatif dan tingkat kecemasan pasien selama wawancara,					5	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		Memberikan umpan balik dan konstruktif, menjelaskan peran perawat dalam pengasuhan keperawatan pasien, Memberdayakan pasien untuk mengambil peran aktif dalam mengungkapkan keluhan dan apa yang dirasakan pasien, harapan pasien terhadap asuhan yang akan diterima, Memberikan edukasi tentang cara mengatasi kondisi sesak, menginformasikan bagaimana cara mengelola kecemasan atau manajemen kecemasan, Mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh pasien dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang menguatkan atau yang meneguhkan pasien saat menyampaikan informasi (misalnya: oke, baik, lanjutkan, hmmm, dll) Menggunakan ungkapan empati terkait perasaan						

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		dan pikiran yang dikemukakan pasien saat wawancara Menggunakan kata-kata yang dipahami oleh pasien sepanjang wawancara Mengajukan pertanyaan dan anamneses dalam wawancara yang dilakukan sesuai dengan tujuan pertemuan						
4	Perilaku professional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsive					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION:
Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Keluhan
Sesak Napas dan Komunikasi Belum Efektif

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus dan melakukan anamnesis kepada pasien Tn A dengan keluhan sesak napas. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik Tn. A dengan keluhan sesak napas dan menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian data fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah keterampilan wawancara keperawatan dalam melakukan anamnesis dengan tehnik wawancara menggunakan active listening dan empati, dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi Tn A dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
4. Perilaku Profesional, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan Tn A/keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus Tn A dengan keluhan sesak napas	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu menggali data fokus dan data relevan.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti kapan dirasakan, bagaimana sesak dirasakan, apakah Tn A merasakan nyeri dada, seberapa sering intensitas nyeri dirasakan, kondisi apa dan	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi merasakan nyeri dada, seberapa sering intensitas nyeri dirasakan, kondisi apa dan bagaimana tindakan yang dapat mengurangi keluhan (sesak dan rasa nyeri dada) kemudian mampu menyampaikan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			bagaimana tindakan yang dapat mengurangi keluhan (sesak dan rasa nyeri pada dada) tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan Tn A dengan keluhan sesak.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan anamnesis dengan tehnik active listening dan empati atau	Melakukan anamnesis dengan tehnik active listening dan	Melakukan anamnesis dengan tehnik active listening dan empati	Melakukan anamnesis dengan tehnik active listening dan empati

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan tidak menunjukkan keterampilan wawancara yang tepat.	empati namun masih belum benar, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	secara tepat dan benar, meliputi penggunaan pertanyaan terbuka dan tertutup, memberikan pernyataan-pernyataan menguatkan ungkapan atau keluhan yang disampaikan oleh pasien (misalnya: oke, baik, lanjutkan, hmmm, dll), menunjukkan perasaan empati terhadap keluhan yang disampaikan pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam tehnik wawancara dan active listening dan empati, komunikasi terapeutik,	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, anamnesis dilakukan dengan tehnik active listening dan empati, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi tehnik anamnesis dengan keterampilan wawancara dengan menggunakan tehnik active listening dan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	kenyamanan pasien.	tidak dilaksanakan dengan benar.	privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	empati komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan Tn A dengan sesak napas dan nyeri dada, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji:.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Tn A dengan Keluhan Sesak Napas
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Tn A dengan Sesak Napas.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada Tn A dengan Keluhan Sesak Napas
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang ketampilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas
	mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	melakukan wawancara, tetapi juga dari kemampuannya melakukan anamneses dengan tehnik active listening dan empati, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien dengan empati
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang pasien laki-laki, Tn. A, usia 45 tahun, datang ke Rumah Sakit dengan keluhan utama sesak napas sejak 2 hari terakhir. Pasien tampak gelisah, sering menarik napas dalam, dan berbicara dengan kalimat pendek. Pasien tampak cemas dan beberapa kali memegang dada. Riwayat penyakit sebelumnya belum tergalil dengan jelas, pasien baru masuk ruang IGD, komunikasi belum terjalin efektif.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian/anamneses menggunakan keterampilan wawancara dengan tehnik active listening (menjaga kontak mata, menyampaikan pernyataan yang menguatkan atau merepon keluhan/informasi yang disampaikan pasien, seperti: baik, oke, lanjutkan, hmmm, dll)
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, anamnesis menggunakan tehnik wawancara active listening	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali data fokus pasien Tn A dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada, mampu menggali data data yang relevan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas
	dan empati, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	dengan keluhan pasien, mampu menerapkan tehnik wawancara dengan active listening (mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan Bahasa verbal dan nonverbal yang tepat, memberikan penguatan terhadap informasi atau keluhan yang disampaikan pasien dengan menganggukkan kepada, menguatkan perkataan seperti: baiklah, oke, lanjutkan, hmmm) dan empati (mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian, menjaga kontak mata atau Bahasa nonverbal yang tepat untuk menguatkan pasien atau memberikan dukungan terhadap perasaan cemas atau nyeri yang dirasakan)
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menerapkan keterampilan wawancara menggunakan tehnik active listening dan empati, serta mampu menjalin komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan anamnesis dan mampu menggali data fokus dan data relevan, serta mampu melakukan wawancara dengan tehnik active listening dan empati, tetapi masih perlu memperdalam penerapan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas
		active listening dan empati dengan tepat.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan anamneses dan dapat menggali data fokus dan data relevan dengan menerapkan active listening dan empati kepada pasien dan keluarga pasien.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus Tn A dengan sesak napas, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi	Pada asuhan keperawatan Tn A dengan sesak napas , portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan anamnesis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
	mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	dengan menerapkan wawancara melalui tehnik active listening dan empati.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan anamnesis pada pasien yang komunikasinya belum terjalin efektif , tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya menerapkan keterampilan wawancara dengan tehnik active listening dan mampu menerapkan empati kepada pasien dan keluarga
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan wawancara, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa menerapkan active listening dan empati.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menerapkan active listening dengan menjaga kontak mata dengan pasien, menggunakan Bahasa nonverbal yang tepat, meberikan pernyataan yang mendukung keluhan atau informasi yang disampaikan pasien seperti oke, baik, lanjutkan, hmmm, dll

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya active listening dan menerapkan empati kepada pasien dan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam keterampilan wawancara, mahasiswa mampu melakukan anamnesis dengan tehnik active listening dan empati, mahasiswa mampu menggali data fokus dan data yang relevan dengan tepat, lengkap, sistematis dan benar.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus Tn A dengan sesak napas tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan keterampilan wawancara menggunakan tehnik active listening dan empati secara, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan anamneses, menggali data fokus, menggali data relevan saat melakukan anamneses dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
		wawancara mahasiswa mampu menerapkan tehnik active listening dengan menjaga kontak mata, mendengarkan semua keluhan pasien dengan penuh empati
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan Tn A dengan sesak napas, mahasiswa tidak hanya mampu menjalin komunikasi afektif, anamneses yang dilakukan dapat menggali data fokus dan data relevan dengan tepat dan benar tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Tuan A dengan Sesak napas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien laki-laki, Tn. A, usia 45 tahun, datang ke Rumah Sakit dengan keluhan utama sesak napas sejak 2 hari terakhir. Pasien tampak gelisah, sering menarik napas dalam, dan berbicara dengan kalimat pendek. Pasien tampak cemas dan beberapa kali memegang dada. Riwayat penyakit sebelumnya belum tergal dengan jelas, pasien baru masuk ruang IGD, komunikasi belum terjalin efektif.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menggali data fokus dan data relevan, mampu menjalin komunikasi efektif dengan menerapkan ketrampilan wawancara melalui tehnik active listening dan empati..
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus Tn A dengan sesak napas, mahasiswa menerapkan komunikasi efektif untuk menggali riwayat kesehatan sebelumnya, menggali data fokus dan data yang relevan untuk menegakkan diagnosis Tn A dengan tepat, melakukan anamnesis kepada Tn A untuk mendapatkan informasi yang lengkap
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menerapkan keterampilan wawancara dengan tehnik yang tepat dengan menerapkan active listening dan empati pada saat membangun komunikasi dengan pasien.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari Tn A, mahasiswa belajar bahwa komunikasi efektif menggunakan tehnik active listening dan empati dapat meningkatkan asuhan kepada pasien dalam melakukan pengkajian yang tepat sehingga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif
		data fokus dapat digali dan data yang relevan dapat dikaji dengan tepat dan benar untuk menetapkan diagnose pasien dan mendukung asuhan keperawatan yang diberikan kepada Tn A. Komunikasi yang efektif sangat penting dilakukan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarga.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu melakukan anamneses melalui penerapan keterampilan wawancara dengan tehnik active listening dan empati tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Tn A dengan Sesak Napas dan komunikasi belum efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napas dan komunikasi belum efektif
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus Tn A dengan sesak napas dan komunikasi belum efektif bila anamneses tidak dilakukan dengan tepat dapat menyebabkan data fokus tidak digali secara lengkap, data relevan tidak dapat dikaji secara tepat, hal ini akan menyebabkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napada dan komunikasi belum efektif
		diagnosa keperawatan yang ditegakkan kurang tepat, komunikasi tidak efektif, pasien merasa tidak nyaman dan asuhan tidak dapat diberikan dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan masalah kesehatan pasien tidak ditangani dengan tepat dan berdampak besar pada asuhan keperawatan yang diberikan kepada Tn A.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada Tn A adalah riwayat penyakit sebelumnya yang belum tergalil dengan jelas, akan menyebabkan penanganan asuhan saat ini tidak tepat, penegakan diagnose tidak tepat karena data data yang digunakan sebagai penegakan diagnosa belum tergalil secara lengkap, penanganan Tn A belum tepat apabila komunikasi perawat dan pasien tidak berjalan dengan efektif. Pasien merasa tidak nyaman dan tidak dapat mengungkapkan dnegan tepat keluhan yang dirasakan saat ini dan riwayat penyakit sebelumnya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan status

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tn A dengan Sesak Napada dan komunikasi belum efektif
	mengenal situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	hidrasi, berkurangnya jumlah urin, muntah berulang, kesalahan pemberian oralit, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda dehidrasi secara berkala, mencatat intake-output dengan teliti, menjelaskan cara pemberian oralit yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada anak dengan diare, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

I. Ringkasan

Asuhan Keperawatan pada Tuan A dengan Sesak Napas dan Komunikasi belum efektif

Bab ini menekankan bahwa keterampilan wawancara keperawatan dalam melakukan anamnesis dengan menggunakan active listening dan empati dapat meningkatkan komunikasi yang efektif serta membina hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Keterampilan wawancara tidak hanya meliputi bagaimana melakukan pengkajian namun bagaimana menerapkan keterampilan wawancara, active listening dan empati. Perawat dalam menerapkan keterampilan wawancara perlu menekankan active listening dengan tepat, bagaimana fokus pada pasien (kontak mata, Bahasa tubuh/nonverbal), tidak memotong pembicaraan, memberikan respon verbal dan nonverbal yang tepat (anggukan, iya, tidak, oke, baik, lanjutkan). Perawat juga dapat menerapkan empati (memahami perasaan pasien, cemas, dan rasa takut karena sesak), terjalannya komunikasi terapeutik dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami pasien nada suara tenang dan jelas.

Mahasiswa perlu memahami bahwa komunikasi efektif yang dilakukan dengan tepat dapat menggali data fokus pada pasien dan data yang relevan sehingga menghindari dari kesalahan dalam penegakan diagnose keperawatan dan asuhan keperawatan secara menyeluruh. Kondisi sesak pada Tuan A dapat menyebabkan kecemasan tinggi, komunikasi terganggu (bicara pendek/terputus). Pasien mungkin lebih fokus pada napas daripada berbicara, membutuhkan pertanyaan singkat dan spesifik. Pentingnya anamnesis dilakukan secara tepat, mengkaji fisik dan psikologis pasien dengan benar, menghindari komunikasi yang membebani pasien. Keterampilan wawancara pada perawat dalam melakukan asuhan pada Tuan A dengan benar akan membuat Tuan A merasa nyaman dan hubungan komunikasi terapeutik dalam berjalan efektif.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum pola napas tidak efektif, gangguan komunikasi verbal. Kecemasan, lalu dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap frekwensi napas, tanda-tanda vital dan nyeri dada yang dialami oleh Tuan A. Berdasarkan kondisi Tuan A perawat mengidentifikasi masalah keperawatan adalah gangguan pola napas, pola napas tidak efektif, gangguan rasa nyaman nyeri, gangguan komunikasi verbal. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, gangguan pola napas dan pola napas tidak efektif dan gangguan komunikasi verbal (komunikasi belum efektif). Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pada penanganan pola napas, menerapkan keterampilan wawancara dengan tehnik active listening dan empati.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain penganganan pola napas tidak efektif, melakukan anamnesis dengan penerapan keterampilan wawancara menggunakan tehnik active listening dan empati untuk menggali riwayat kesehatan lalu secara tepat. Saat melakukan anamnesis dengan wawancara perawat menggunakan pertanyaan yang singkat dan tertutup terlebih dahulu, seperti, "sesak sejak kapan?", "apakah terasa berat?". Perawat dapat mengkombinasikan dengan pertanyaan terbuka, "bagaimana dirasakan?", saat kondisi sudah membaik. Pada saat pasien menjawab pertanyaan yang diajukan dengarkan tanpa interupsi, jawaban pasien yang singkat dapat diparafrase, "jadi Bapak merasa sesaknya semakin berat saat malam hari? Apakah benar?", "jika bapak beraktivitas, turun dari tempat tidur saja, bapak sudah merasakan sesak lebih berat?". Lakukan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban yang kurang jelas. Perawat juga menerapkan empati pada saat melakukan wawancara, validasi perasaan yang dialami Tuan A, "wajar Bapak merasa cemas dengan kondisi ini", berikan rasa aman kepada pasien. "kami akan membantu Bapak mengatasi sesak, agar bapak dapat bernapas lebih nyaman". Lakukan tehnik pendukung menguatkan perasaan pasien menunjukkan empati yang dalam, gunakan komunikasi nonverbal; sentuhan terapeutik (jika sesuai, misalnya menyentuh punggung telapak tangan untuk menguatkan), menampilkan ekspresi wajah tenang. Saat melakukan wawancara beri waktu jeda untuk bernapas, gunakan alat bantu atau isyarat jika pasien sulit bicara atau mengalami sesak. Lakukan observasi klinis; tanda distress napas (RR, Penggunaan otot bantu pernapasan; abdomen, tanda cuping hidung), manajemen waktu wawancara dengan baik; tidak terlalu lama (menyesuaikan dengan kondisi pasien), pengaturan lingkungan yang tenang, minim distraksi. Pengendalian diri perawat; tidak panik, tetap fokus pada wawancara yang telah ditetapkan. Kolaborasi dengan tim medis jika kondisi pasien memburuk.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat kondisi dan respon pasien, pasien mampu menyampaikan keluhan meski terbatas, mampu menjawab pertanyaan dengan lebih jelas dari waktu ke waktu, terjadi penurunan kecemasan, kontak mata meningkat, respon pasien lebih kooperatif. Pasien Nampak lebih tenang, mampu menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek, komunikasi mulai berjalan efektif. Tindak lanjut jika komunikasi masih perlu ditingkatkan; modifikasi metode komunikasi, gunakan alat bantu, libatkan keluarga pasien.

Dengan demikian, inti bab ini adalah penerapan keterampilan wawancara dengan tehnik active listening dan empati perlu diterapkan dalam asuhan keperawatan pasien, kunci keberhasilan wawancara pada pasien adalah menengahkan secara aktif dan empati. Pada setiap pasien metode komunikasi dan

keterampilan wawancara dapat dimodifikasi, pada pasien sesak napas, perlu dilakukan komunikasi dengan tehnik active listening dengan cara mendengar dengan penuh perhatian, memahami dan merepson perasaan pasien (empati), menyesuaikan tehnik komunikasi yang tepat dengan keadaan pasien. Dengan pendekatan keterampilan wawancara menggunakan tehnik mendengarkan secara aktif (active listening) dan empati dapat meningkatkan komunikasi efektif pada psaien meskipun kondisi pasien terbatas, sehingga asuhan keperawatan dapat berjalan optimal dan dapat berpusat pada pasien.

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Tuan A dengan Sesak Napas

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sesak napas semakin berat (tidak membaik dengan istirahat)	Menunjukkan perburukan respirasi, resiko gagal napas	Segera laporkan ke dokter, posisikan semi/higher fowler, siapkan oksigen
Frekwensi napas >30x/menit atau <10x/menit	Distres napas berat/depresi napas	Monitor ketat, berikan O2, sesuai Indikasi, siapkan alat resusitasi
Penggunaan otot bantu napas (retraksi, cuping hidung)	Upaya kompensasi tubuh: tanda hipoksia	Observasi intensif, kolaborasi pemberian terapi oksigen
Saturasi Oksigen <92%	Hipoksemia	Berikan oksigen segera, evaluasi respons, kolaborasi terapi lanjut
Sianosis (bibir/kuku kebiruan)	Kekuarangan Oksigen berat	Tindakan emergensi, oksigen high flow, rujuk segera
Pasien tampak gelisah/penurunan kesadaran	Hipoksia atau hiperkapnia	Evaluasi neurologis, lapor segera, siapkan airway management
Tidak mampu berbicara (hanya 1-2 kata)	Sesak berat, ventilasi terganggu	Hentikan wawancara panjang, gunakan komunikasi singkat/nonverbal

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Bunyi napas abnormal (wheezing berat/tidak terdengar)	Obstruksi jalan napas/silent chest (gawat)e	Segera kolaborasi tindakan medis, siapkan nebulasi/rujuk
Nyeri dada hebat	Kemungkinan masalah kardiopulmoner serius (emboli, infark)	Segera lapor dokter, monitor tanda vital, siapkan EKG
Batuk darah (hemoptisis)	Kemungkinan infeksi berat/gangguan paru serius	Hentikan wawancara, lapor segera, siapkan rujukan
Komunikasi sangat tidak efektif (tidak respon/bingung)	Hipoksia atau gangguan neurologis	Gunakan alat bantu komunikasi, evaluasi kesadaran, lapor segera
Tanda vital tidak stabil (TD turun, nadi cepat > 120x/menit)	Syok atau kegagalan sistemik	Aktifkan tim emergency, monitoring intensif, kolaborasi segera

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab Keterampilan Wawancara dengan anamnesis, active listening dan empati

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
A	Tahap persiapan			
1	Saya sudah bisa menyiapkan lingkungan yang tenang dan menjaga privasi pasien, menunjukkan sikap profesional; tenang percaya diri	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional; tenang percaya diri	☐	☐	_____
B	Tahap Orientasi			
3	Saya sudah bisa memberi salam dan memperkenalkan diri dengan tepat	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
A	Tahap persiapan			
4	Saya sudah bisa verifikasi identitas pasien secara lengkap dan tepat	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan wawancara secara singkat dan dapat dipahami pasien dengan baik			
C	Tahap Kerja (Active listening dan Empati)			
6	Saya sudah bisa melakukan pengkajian atau anamnesis dengan menerapkan keterampilan wawancara	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menerapkan wawancara dengan manajemen tata kelola wawancara dan keterampilan wawancara yang sistematis dan sesuai dengan keadaan/kondisi pasien	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menggali data fokus pasien dan data relevan yang dibutuhkan untuk memperjelas riwayat penyakit pasien	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan teknik active listening dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup secara singkat dan jelas	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menerapkan active listening dengan menjaga kontak mata, menggunakan Bahasa tubuh terbuka, tidak memotong pembicaraan pasien, memberikan respon verbal dengan tepat (angguka, "ya", "baik")	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi pasien Tn A dengan sesak napas	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa melakukan parafrase (mengulang inti keluhan)	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melakukan klarifikasi jika informasi kurang jelas	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa mengidentifikasi perasaan pasien terhadap kondisinya (cemas/tidak nyaman)	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
A	Tahap persiapan			
15	Saya sudah bisa mengungkapkan empati secara verbal	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan tenang, intonasi suara yang lembut dan menenangkan	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa melakukan penguatan pada pasien, tidak menghakimi atau menyalahkan pasien	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa memberikan dukungan secara emosional kepada pasien dengan fokus pada pasien saat melakukan wawancara	☐	☐	
19	Saya sudah bisa memperhatikan dengan cermat kondisi Tuan A dengan sesak selama proses wawancara, memberi waktu pasien untuk bernapas sebelum menjawab pertanyaan, menghindari pertanyaan panjang dan berulang, menghentikan wawancara jika kondisi memburuk	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa mengobservasi tanda distress napas	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya (red flags)	☐	☐	
23	Saya sudah bisa melakukan tindakan cepat/ekskalasi bila diperlukan	☐	☐	_____
D	Tahap Terminasi (Penutup)			
24	Saya sudah bisa merangkum hasil wawancara secara tepat, lengkap dan benar	☐	☐	_____
25	Saya sudah bisa memberikan kesempatan kepada pasien bertanya tentang kondisinya	☐	☐	_____
26	Saya sudah bisa memberikan edukasi singkat sesuai kondisi pasien	☐	☐	
27	Saya sudah bisa menyampaikan rencana tindak lanjut kepada klien	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
A	Tahap persiapan			
28	Saya sudah bisa menutup wawancara dengan sikap sopan	☐	☐	_____
29	Saya sudah bisa melakukan sesi wawancara dengan tepat dan menjaga keamanan pasien selama sesi tanya jawab	☐	☐	
30	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat wawancara dan melakukan anamnesis pada Tuan A	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

K. Daftar Pustaka

- Centikaya, Z. e. (2025, October 7). Development of an interview skills assessment checklist for nursing students: Validity and reliability study. *Journal Of Psychiatric Nursing*, 254-259. doi:DOI: 10.14744/phd.2025.15921
- Grimm, T. R. (2015). *The Art of Communication in Nursing and Health Care, An Interdisciplinary Approach*. Ney Work: Springer Publishing Company.
- Harry Weger, J. G. (2014, April 9). The Relative Effectiveness of Active Listening in Initial Interactions. *The Intl. Journal of Listening*, 28, 13-31. doi:DOI: 10.1080/10904018.2013.813234
- Marijan Tustonja, D. T. (2023, Desember 18). Active Listening - A Model Of Empathic Communication in The Helong Professions. *Medicina Academica Integrativa*, 42-47. Retrieved March 27, 2026, from [researchgate.net/publication/379083877_ACTIVE_LISTENING_- A_MODEL_OF_EMPATHETIC_COMMUNICATION_IN_THE_HELPING_PROFESSIONS/link/65fa9bfea4857c796260f906/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://researchgate.net/publication/379083877_ACTIVE_LISTENING_-_A_MODEL_OF_EMPATHETIC_COMMUNICATION_IN_THE_HELPING_PROFESSIONS/link/65fa9bfea4857c796260f906/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19)
- Martoredjo, N. T. (2014, April). Keterampilan Mendengarkan secara Aktif dalam Komunikasi Interpersonal. *HUMANIORA*, Vol. 5(I), 501-509. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/167053-ID-keterampilan-mendengarkan-secara-aktif-d.pdf>
- Raphael, T. (2015). *The Art of Communication in Nursing and Health Care, An Interdisciplinary Approach*. (M. Zuccarini, Ed.) New York, New York State, New York: Springer Publishing Company. doi:978-0-8261-1055-8
- Ruth Irmgard Bärtschi Gabatz, E. S. (2018, October 10). Formation and disruption of bonds between caregivers and institutionalized children. (G. RIB, Ed.) *Rev Bras Enferm*, 2650-2658. doi:<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0844>
- Sam Slade, S. R. (2023). *Interview Techniques*. Michigan, Michigan, Amerika Serikat: StatPearls Publishing, Treasure Island (FL). Retrieved April 1, 2026, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526083/?report=reader>
- Suryani. (2017). *Komunikasi Teapeutik (Teori dan Praktik) (Edisi 2 ed., Vol. I)*. (H. B. Egi Komara Yudha, Ed.) Jakarta, Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Tennant1, K., Long, A., & Toney-Butler., T. J. (2023, September 13). Active Listening. 10-16. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442015/?report=printable>

BAB 3

KOMUNIKASI INTERPROFESIONAL DAN KOLABORASI TIM KESEHATAN

1. Identitas Bab

- Mata Kuliah: Komunikasi Keperawatan
- Bab: 6
- CPMK Terkait: CPMK-6 (Menerapkan komunikasi interprofesional, kolaborasi tim, negosiasi, dan eskalasi untuk koordinasi layanan yang efektif).
- CPL Terkait: CPL-4 (Mampu melakukan komunikasi interprofesional, kolaborasi, dan handover terstruktur untuk kesinambungan layanan yang aman).

2. Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menerapkan prinsip kolaborasi tim yang meliputi tujuan bersama, peran, dan respek pada skenario koordinasi layanan.
- Menyampaikan informasi klinis secara ringkas dan relevan kepada tim kesehatan sesuai kebutuhan keputusan klinis.

3. Indikator Ketercapaian

- Ketepatan dalam menjelaskan prinsip kolaborasi interprofesional.
- Kejelasan dalam menyampaikan pesan klinis dan efektivitas kolaborasi tim sesuai rubrik penilaian.
- Ketepatan melakukan eskalasi dengan fokus risiko yang tajam dan terkonfirmasi.

4. Peta Konsep Bab

Komunikasi Interprofesional Budaya Keselamatan Pasien Pilar Kolaborasi (Respek, Kepercayaan, Tujuan Bersama) Hambatan Komunikasi Interdisiplin Teknik Eskalasi Risiko & Negosiasi Koordinasi Layanan Aman.

5. Kata Kunci

Interprofessional communication, kolaborasi tim, eskalasi risiko, koordinasi asuhan, keselamatan pasien, respek mutual, *patient safety*

Uraian Materi

Pelayanan kesehatan modern merupakan sistem yang kompleks dan multidisiplin, di mana berbagai tenaga kesehatan bekerja secara simultan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif. Dalam konteks ini, tidak ada satu profesi pun yang mampu memberikan pelayanan secara optimal tanpa keterlibatan profesi lain. Oleh karena itu, komunikasi interprofesional dan kolaborasi menjadi komponen esensial dalam menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Murdiany et al., 2021).

Komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Dalam praktik pelayanan kesehatan, kualitas komunikasi antarprofesi sangat menentukan keberhasilan asuhan yang diberikan kepada pasien (Berman et al., 2021).

Berbagai bukti menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien. Sekitar 70–80% kesalahan dalam pelayanan kesehatan disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif dalam tim. Selain itu, komunikasi yang buruk berkontribusi terhadap sekitar 66% kejadian sentinel yang berdampak serius terhadap pasien. Kondisi ini menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi merupakan faktor kritis dalam pengambilan keputusan klinis, koordinasi tindakan, dan keberlanjutan asuhan (Faizin et al., 2025).

Kolaborasi interprofesional didefinisikan sebagai kerja sama antara dua atau lebih profesi kesehatan dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dalam pelayanan pasien. Kolaborasi ini menuntut adanya komunikasi yang efektif, saling menghargai peran, serta kemampuan bekerja dalam tim secara sinergis (Faizin et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, kemampuan komunikasi interprofesional merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan langsung, tetapi juga sebagai koordinator pelayanan yang menjembatani komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya (Faizin et al., 2025).

Bab ini akan mengupas tuntas apa itu komunikasi interprofesional dan kolaborasi tim kesehatan, mengapa komunikasi itu dilakukan, bagaimana melakukan, serta apa manfaatnya bagi tenaga kesehatan dan pasien. Bab ini membahas pentingnya komunikasi multidisiplin dalam konteks pelayanan kesehatan. Komunikasi multidisiplin melibatkan

interaksi dan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti keperawatan, kedokteran, farmasi, dan ilmu sosial, untuk mencapai tujuan bersama dalam perawatan pasien.

Dalam bab ini, kita akan menjelaskan konsep dasar komunikasi multidisiplin, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk meningkatkan kolaborasi antar profesi dalam layanan kesehatan.

A. Konsep Komunikasi Interprofesional

Komunikasi interprofesional adalah proses pertukaran informasi, ide, dan keputusan antara tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu dalam rangka memberikan pelayanan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien (Pertiwi et al., 2022). Komunikasi interprofessional merupakan proses interaksi yang terjadi antara berbagai disiplin ilmu dalam sistem pelayanan kesehatan. Interaksi ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi, seperti dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya yang berperan dalam pemberian asuhan kepada pasien (Sarfika, 2025). Komunikasi interprofesional adalah proses pertukaran informasi antarprofesi kesehatan yang berbeda dengan tujuan memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berfokus pada pasien. WHO juga menegaskan bahwa komunikasi interprofesional merupakan pilar utama dalam collaborative practice, yang mendukung pencapaian Universal Health Coverage dengan memastikan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin bekerja secara sinergis (Berman et al., 2021).

Dalam praktiknya, komunikasi multidisiplin tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi untuk menyatukan berbagai perspektif klinis yang berbeda. Setiap profesi membawa pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan yang spesifik, sehingga melalui komunikasi yang efektif, berbagai sudut pandang tersebut dapat diintegrasikan menjadi suatu rencana asuhan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Komunikasi ini melibatkan: dokter, perawat, farmasis/apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya (Berman et al., 2021).

Tujuan utama komunikasi multidisiplin adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kolaborasi yang sinergis antarprofesi. Dengan adanya komunikasi yang terstruktur dan terbuka, tim kesehatan dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan klinis, meminimalkan risiko kesalahan, serta memastikan bahwa kebutuhan pasien terpenuhi secara holistik, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual (Sarfika, 2025).

Komunikasi yang efektif ditandai dengan kejelasan pesan, ketepatan informasi, umpan balik yang konstruktif, minimnya distorsi komunikasi. Sebaliknya komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan diagnosis, kesalahan pemberian terapi, duplikasi tindakan, keterlambatan penanganan (Rokhmah et al., 2017).

Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mencakup kemampuan mendengarkan, memberikan umpan balik, dan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya. Kualitas komunikasi dapat mempengaruhi hasil perawatan, kepuasan pasien, dan keseluruhan pengalaman pasien dalam pelayanan kesehatan (Sarfika, 2025).

B. Konsep Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional merupakan proses kerja sama antar tenaga kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan pasien secara bersama-sama. Karakteristik kolaborasi yang efektif meliputi (Noviyanti et al., 2023):

1. Tujuan bersama (shared goals)
2. Kejelasan peran (role clarity)
3. Saling menghormati (mutual respect)
4. Komunikasi terbuka (open communication)
5. Pengambilan keputusan bersama (shared decision-making)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional mampu meningkatkan kualitas pelayanan (Alfarizi & Nuryana, 2019), mengurangi komplikasi dan kesalahan medis (Keumalasari et al., 2021). menurunkan angka kematian, memperpendek lama rawat pasien (Nur & Santoso, 2018).

C. Model Komunikasi Efektif dalam Kolaborasi Interprofesional

1. SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

SBAR merupakan metode komunikasi terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan informasi klinis secara sistematis. Komunikasi SBAR merupakan suatu standar sistem komunikasi antar tenaga kesehatan guna mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengelolaan pasien. Kerangka komunikasi efektif yang digunakan adalah berbasis SBAR, yang digunakan pada saat perawat melakukan timbang terima (handover), pindah ruang perawatan maupun dalam melaporkan kondisi pasien kepada dokter melalui telepon (Sarfika, 2025).

- a. Situation: kondisi pasien saat ini
- b. Background: riwayat atau informasi pendukung
- c. Assessment: analisis kondisi pasien
- d. Recommendation: rekomendasi tindakan

SBAR terbukti meningkatkan kejelasan komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan klinis .

2. ISBAR (Identification, Situation, Background, Assessment, Recommendation)

ISBAR merupakan pengembangan dari SBAR, dengan menambahkan komponen Identification di awal. Hal ini bertujuan memastikan identitas pasien yang dilaporkan benar, sehingga mengurangi risiko salah pasien. Identification: Identitas pasien (nama, umur, nomor rekam medis). Situation, Background, Assessment, Recommendation: sama seperti SBAR. Contoh: Saat perawat melaporkan hasil laboratorium pasien ke dokter melalui telepon, identitas pasien disebutkan lebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan. Kelebihan: Memastikan keamanan pasien dengan validasi identitas, cocok digunakan di rumah sakit dengan banyak pasien.

3. TBaK (Tulis-Bacakan-Konfirmasi)

Komunikasi Efektif dengan tulis baca konfirmasi (TBaK) adalah teknik komunikais lisan per telepon dengan menulis, membaca ulang, dan melakukan konformasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan (Sarfika, 2025).

T: Tuliskan

Tuliskan pesan yang disampaikan oleh DPJP (pemberi pesan) pada lembar jawaban konsultasi bila menerima jawaban konsul atau pada lembar catatan terintegrasi bila melaporkan kondisi pasien.

Ba: Bacakan

Bacakan kembali (*Read Back*) pesan yang sudah ditulis kepada DPJP (Pemberi pesan). Selesai membacakan pesan, penerima pesan mengingatkan DPJP (pemberi pesan) untuk melakukan konfrimasi. Lakukan pengejaan dengan alphabeth fonetik instruksi yang terkait dengan obat LASA (*Look Alike Sound Alike*).

K: Konfirmasi

Konfirmasi Instruksi atau hasil kritis yang di sebutkan oleh pemberi pesan dengan jawaban "Ya benar, bila sesuai dengan instruksi/pesan yang diberikan sebelumnya. Konfirmasi dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam dengan cara DPJP menuliskan nama, paraf / tandatangan tanggal dan jam kehadiran di kolom stempel Konfirmasi *Read Back* pemberi pesan di formulir catatan Perkembangan Terintegrasi.

Contoh: Dokter memberikan instruksi "berikan paracetamol 500 mg, 3 kali sehari" melalui telepon. Perawat menuliskannya, membacakan ulang, lalu dokter mengonfirmasi kebenarannya. Kelebihan: mencegah kesalahan dosis atau jenis obat, efektif digunakan saat komunikasi jarak jauh.

D. Komunikasi antara perawat dengan dokter

Komunikasi antara perawat dan dokter sangat penting dalam menyediakan perawatan yang efektif dan koordinasi yang baik dalam lingkungan perawatan kesehatan. Komunikasi yang baik memungkinkan perawat dan dokter untuk saling bertukar informasi, mengoordinasikan perawatan pasien, dan bekerja sebagai tim untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien. Contoh komunikasi antara perawat dan dokter:

1. Laporan pasien

Perawat memberikan laporan kepada dokter tentang kondisi pasien, termasuk gejala, tanda-tanda vital, dan perkembangan terkini. Misalnya, seorang perawat memberi tahu dokter bahwa pasien mengalami demam tinggi, tekanan darah rendah, dan kesulitan bernapas.

2. Konsultasi

Ketika menghadapi situasi yang kompleks atau memerlukan masukan tambahan, perawat dapat berkonsultasi dengan dokter. Misalnya, perawat menghubungi dokter untuk meminta saran mengenai perawatan luka yang sulit sembuh.

3. Koordinasi perawatan

Perawat dan dokter bekerja sama untuk merencanakan perawatan pasien. Mereka membahas rencana perawatan, pengobatan, dan intervensi yang diperlukan. Misalnya, perawat dan dokter membahas jadwal obat yang harus diberikan kepada pasien.

4. Pelaporan hasil

Setelah melaksanakan rencana perawatan, perawat melaporkan hasil perawatan kepada dokter. Misalnya, perawat memberi tahu dokter bahwa pasien menunjukkan peningkatan kondisi setelah menerima terapi antibiotik.

5. Pengembalian informasi

Perawat memberikan informasi mengenai respons pasien terhadap pengobatan atau perawatan yang diberikan kepada dokter. Misalnya, perawat memberitahu dokter bahwa pasien mengalami efek samping setelah mengonsumsi obat tertentu. Permintaan dan pertanyaan Perawat dapat menghubungi dokter untuk meminta perubahan resep obat, pesan laboratorium, atau pertanyaan terkait perawatan pasien. Misalnya, perawat meminta dokter untuk memesan tes darah tambahan untuk memonitor efek pengobatan pasien.

E. Komunikasi Perawat dengan Ahli Terapi

1. Pengertian Komunikasi Perawat dan Ahli Terapi

Komunikasi antara perawat dan ahli terapi medik merupakan proses pertukaran informasi, ide, serta pengalaman klinis yang berkaitan dengan perawatan pasien. Komunikasi ini mencakup aspek verbal maupun nonverbal yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan bersama, yaitu optimalisasi pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, komunikasi antara perawat dan tenaga terapi seperti fisioterapis, terapis okupasi, maupun terapis wicara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang terintegrasi dan holistik. Kedua profesi ini bekerja secara kolaboratif dalam menyusun rencana asuhan, melaksanakan intervensi, serta mengevaluasi respons pasien terhadap terapi yang diberikan.

Kolaborasi yang efektif antara perawat dan fisioterapis memungkinkan terjadinya sinkronisasi tindakan klinis, sehingga setiap intervensi yang diberikan dapat saling mendukung dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh.

2. Bentuk dan Situasi Komunikasi Perawat dengan Ahli Terapi

a. Pertukaran Informasi Pasien

Perawat berperan dalam menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi pasien kepada fisioterapis untuk mendukung perencanaan intervensi yang tepat.

Contoh:

"Pasien di ruang 207 pasca operasi penggantian lutut masih mengalami nyeri dengan skala 7/10. Perlu penyesuaian waktu latihan mobilisasi agar tidak bertepatan dengan efek maksimal analgesik."

b. Konsultasi dan Kolaborasi

Perawat melakukan konsultasi dengan ahli terapi terkait kondisi pasien yang memerlukan penilaian dan intervensi khusus.

Contoh:

"Pasien pasca stroke di ruang 305 mengalami kesulitan menelan. Mohon dilakukan evaluasi untuk menentukan kebutuhan modifikasi diet dan latihan menelan guna mencegah risiko aspirasi."

c. Perencanaan Perawatan

Perawat dan fisioterapis bekerja sama dalam merancang rencana perawatan yang komprehensif, termasuk penentuan tujuan terapi, jadwal, dan jenis intervensi.

Contoh:

“Pasien dengan fraktur femur akan memulai program rehabilitasi. Apakah memungkinkan dilakukan terapi fisik dua kali sehari dengan fokus pada latihan penguatan otot?”

d. Evaluasi Respons Pasien

Setelah intervensi dilakukan, perawat dan fisioterapis bersama-sama mengevaluasi perkembangan pasien untuk menentukan tindak lanjut perawatan.

Contoh:

“Setelah terapi fisik, pasien tampak lebih stabil menggunakan alat bantu jalan, namun mengeluhkan pusing saat berdiri. Perlu evaluasi lebih lanjut terkait keseimbangan dan toleransi aktivitas.”

e. Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat dan ahli terapi berkolaborasi dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga terkait latihan, penggunaan alat bantu, serta perawatan lanjutan di rumah.

Contoh:

“Pasien membutuhkan edukasi penggunaan alat bantu saat berpakaian. Mari kita berkoordinasi untuk memberikan penjelasan bersama kepada pasien dan keluarga.”

Komunikasi yang terbuka, terstruktur, dan berkesinambungan antara perawat dan fisioterapis sangat penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Tujuan Komunikasi Perawat dan Ahli Terapi

Tujuan utama komunikasi antara perawat dan ahli terapi meliputi:

a. Koordinasi Perawatan

Memastikan seluruh anggota tim kesehatan memiliki pemahaman yang sama mengenai rencana perawatan pasien.

b. Pertukaran Informasi

Menyampaikan informasi terkini terkait kondisi pasien, perkembangan terapi, dan kebutuhan spesifik pasien.

c. Meningkatkan Efektivitas Terapi

Mendukung penyusunan intervensi terapi yang lebih tepat dan berbasis kondisi aktual pasien.

d. Dukungan Profesional dan Emosional

Membangun hubungan kerja yang saling mendukung sehingga meningkatkan kinerja tim dan kualitas pelayanan.

- e. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi
Menggunakan sistem informasi kesehatan atau platform digital untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran data pasien secara akurat.
- f. Membangun Hubungan Kolaboratif
Meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antarprofesi melalui interaksi yang profesional dan saling menghargai.

4. Tantangan dalam Komunikasi Perawat dan Ahli Terapi

Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam komunikasi interprofesional antara perawat dan ahli terapi antara lain:

- a. Perbedaan Terminologi
Setiap profesi memiliki istilah teknis yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
- b. Keterbatasan Waktu
Beban kerja yang tinggi dapat menghambat komunikasi yang efektif dan mendalam.
- c. Kurangnya Pelatihan Komunikasi Interprofesional
Tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan komunikasi lintas profesi yang memadai.
- d. Perbedaan Persepsi dan Prioritas Klinis
Perbedaan sudut pandang dalam menentukan prioritas perawatan dapat menimbulkan konflik.

5. Strategi Peningkatan Komunikasi Perawat dan Ahli Terapi

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi, dapat dilakukan beberapa strategi berikut:

- a. Pelatihan Interprofesional
Menyelenggarakan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman peran dan keterampilan komunikasi antarprofesi.
- b. Rapat Tim Secara Berkala
Melakukan diskusi rutin terkait perkembangan pasien sehingga semua anggota tim dapat memberikan kontribusi.
- c. Penggunaan Model Komunikasi Terstruktur
Menerapkan metode seperti SBAR untuk meningkatkan kejelasan dan efisiensi komunikasi klinis.
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi Kesehatan
Menggunakan sistem dokumentasi elektronik untuk mendukung komunikasi yang cepat dan akurat.
- e. Penguatan Budaya Kolaboratif

Membangun lingkungan kerja yang terbuka, saling menghargai, dan bebas dari budaya hierarki yang berlebihan.

F. Komunikasi Perawat dengan Ahli Farmasi

1. Pengertian Komunikasi Perawat dan Ahli Farmasi

Komunikasi antara perawat dan ahli farmasi merupakan proses pertukaran informasi klinis yang berkaitan dengan terapi obat pasien, meliputi indikasi, dosis, cara pemberian, efek samping, serta potensi interaksi obat. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima terapi farmakologis yang aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi klinisnya.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan kerja antara perawat dan ahli farmasi memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan pasien (patient safety), khususnya dalam mencegah medication error. Perawat sebagai tenaga yang berinteraksi langsung dengan pasien berperan dalam pemberian obat dan pemantauan respons pasien, sedangkan ahli farmasi memiliki kompetensi dalam manajemen terapi obat. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara kedua profesi ini menjadi kunci dalam optimalisasi terapi.

2. Bentuk dan Situasi Komunikasi Perawat dengan Ahli Farmasi

a. Pertukaran Informasi Terapi Obat

Perawat memberikan informasi terkait kondisi pasien dan riwayat penggunaan obat untuk mendukung analisis farmasi yang tepat.

Contoh:

"Pasien di ruang 212 memiliki riwayat alergi terhadap penisilin. Mohon dipastikan alternatif antibiotik yang diberikan aman, serta konfirmasi kesesuaian dosis dengan kondisi pasien."

b. Konsultasi dan Kolaborasi Terkait Terapi Obat

Perawat dapat berkonsultasi dengan ahli farmasi dalam menentukan pemilihan obat, penyesuaian dosis, serta cara pemberian obat berdasarkan kondisi pasien.

Contoh:

"Pasien dengan gagal ginjal kronis mengalami peningkatan kreatinin. Apakah diperlukan penyesuaian dosis obat antihipertensi untuk mencegah perburukan fungsi ginjal?"

c. Perencanaan Pemberian Obat

Perawat dan ahli farmasi bekerja sama dalam merencanakan pemberian obat, terutama pada terapi dengan risiko tinggi seperti kemoterapi, insulin, atau obat-obatan kritis lainnya.

Contoh:

"Pasien akan memulai kemoterapi besok. Mohon dipastikan ketersediaan obat suportif seperti antiemetik sebelum terapi dimulai."

d. Pencegahan Efek Samping dan Interaksi Obat

Ahli farmasi berperan dalam mengidentifikasi potensi interaksi obat dan efek samping, sementara perawat memberikan informasi terkait respons pasien terhadap terapi.

Contoh:

"Pasien mengalami mual dan muntah setelah pemberian metformin. Apakah perlu dilakukan penyesuaian dosis atau penggantian obat?"

e. Evaluasi dan Pemantauan Terapi Obat

Perawat melakukan pemantauan klinis terhadap pasien, sedangkan ahli farmasi membantu mengevaluasi efektivitas dan keamanan terapi obat.

Contoh:

"Pasien yang mendapat warfarin menunjukkan peningkatan INR secara signifikan. Apakah perlu dilakukan penyesuaian dosis atau intervensi tambahan?"

f. Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat dan ahli farmasi berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat, efek samping, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi.

Contoh:

"Saya akan memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan insulin. Mohon bantuan untuk menjelaskan teknik penyuntikan dan pemantauan kadar gula darah."

Komunikasi yang efektif antara perawat dan ahli farmasi sangat penting untuk memastikan keamanan terapi, mencegah kesalahan pengobatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

3. Tujuan Komunikasi Perawat dan Ahli Farmasi

Komunikasi antara perawat dan ahli farmasi bertujuan untuk:

a. Koordinasi Terapi Obat

Memastikan seluruh tim kesehatan memiliki pemahaman yang konsisten terkait rencana pengobatan pasien.

b. Peningkatan Keselamatan Pasien

Mengidentifikasi dan mencegah potensi kesalahan obat, termasuk reaksi alergi, interaksi obat, dan kesalahan dosis.

c. Optimalisasi Terapi

Memanfaatkan keahlian farmasi untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko efek samping.

d. Edukasi Pasien

Memberikan informasi yang jelas kepada pasien terkait penggunaan obat, efek samping, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi.

e. Pemantauan dan Evaluasi Terapi

Menilai respons pasien terhadap terapi obat untuk menentukan tindak lanjut yang tepat.

4. Tantangan dalam Komunikasi Perawat dan Ahli Farmasi

Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam komunikasi antara perawat dan ahli farmasi meliputi:

a. Perbedaan Terminologi Profesional

Penggunaan istilah teknis yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi.

b. Keterbatasan Waktu

Beban kerja yang tinggi dapat membatasi kesempatan untuk melakukan komunikasi yang efektif.

c. Kurangnya Pemahaman Peran

Ketidajelasan terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dapat menghambat kolaborasi.

d. Kurangnya Sistem Komunikasi Terintegrasi

Keterbatasan sistem informasi kesehatan dapat memperlambat pertukaran informasi.

5. Strategi Peningkatan Komunikasi Perawat dan Ahli Farmasi

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi, dapat dilakukan beberapa strategi berikut:

a. Pelatihan Interprofesional

Menyelenggarakan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman peran dan keterampilan komunikasi antarprofesi.

b. Rapat Tim Secara Berkala

Melakukan diskusi rutin terkait kasus pasien untuk meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan bersama.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Kesehatan

Menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat dan akurat.

- d. Penerapan Komunikasi Terstruktur
Menggunakan metode seperti SBAR untuk meningkatkan kejelasan dan efisiensi komunikasi klinis.
- e. Penguatan Hubungan Profesional
Membangun hubungan kerja yang saling percaya dan menghargai untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi.

G. Komunikasi Perawat dengan Ahli Gizi

1. Pengertian Komunikasi Perawat dan Ahli Gizi

Komunikasi antara perawat dan ahli gizi merupakan proses pertukaran informasi yang berkaitan dengan kebutuhan nutrisi pasien, meliputi perencanaan diet, jenis dan komposisi makanan, serta respons pasien terhadap intervensi nutrisi yang diberikan. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memperoleh terapi nutrisi yang tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi klinisnya.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, kolaborasi antara perawat dan ahli gizi memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan pasien. Perawat sebagai tenaga yang berinteraksi langsung dengan pasien berperan dalam pemantauan asupan dan kondisi klinis, sedangkan ahli gizi bertanggung jawab dalam merancang intervensi nutrisi yang sesuai. Sinergi kedua profesi ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan nutrisi pasien secara optimal sebagai bagian dari pendekatan asuhan yang holistik.

2. Bentuk dan Situasi Komunikasi Perawat dengan Ahli Gizi

a. Pertukaran Informasi Status Nutrisi Pasien

Perawat menyampaikan data klinis dan kondisi pasien yang berkaitan dengan status nutrisi untuk mendukung perencanaan diet yang tepat.

Contoh:

"Pasien di ruang 307 mengalami penurunan berat badan sebesar 3 kg dalam satu minggu terakhir, disertai penurunan nafsu makan dan kelemahan umum. Mungkin diperlukan penyesuaian diet atau suplementasi nutrisi."

b. Konsultasi dan Kolaborasi Terkait Diet Khusus

Perawat berkonsultasi dengan ahli gizi terkait penyesuaian diet sesuai kondisi medis pasien.

Contoh:

"Pasien dengan diabetes melitus tipe 2 membutuhkan pengaturan asupan karbohidrat. Mohon rekomendasi diet yang seimbang untuk membantu mengontrol kadar glukosa darah."

c. Perencanaan dan Implementasi Diet

Perawat dan ahli gizi bekerja sama dalam merencanakan serta melaksanakan diet sesuai kebutuhan pasien.

Contoh:

"Pasien pascaoperasi di ICU memerlukan diet tinggi protein untuk mendukung penyembuhan. Apakah dapat dilakukan penyesuaian komposisi nutrisi pada diet cairnya?"

d. Pemantauan dan Evaluasi Status Nutrisi

Perawat memantau respons pasien terhadap diet, sementara ahli gizi mengevaluasi efektivitas intervensi nutrisi.

Contoh:

"Setelah penerapan diet rendah natrium, tekanan darah pasien membaik, namun pasien mengeluhkan penurunan selera makan. Apakah ada alternatif untuk meningkatkan palatabilitas makanan tanpa menambah natrium?"

e. Penanganan Masalah Nutrisi

Perawat melaporkan masalah terkait nutrisi seperti mual, muntah, atau intoleransi makanan untuk dilakukan penyesuaian diet.

Contoh:

"Pasien mengalami mual setelah konsumsi makanan berlemak. Apakah perlu modifikasi diet dengan menurunkan kandungan lemak dan mengganti sumber energi?"

f. Edukasi Pasien dan Keluarga

Perawat dan ahli gizi berkolaborasi dalam memberikan edukasi terkait pola makan dan kepatuhan diet.

Contoh:

"Saya akan memberikan edukasi terkait pola makan pasien setelah pulang. Mohon bantuan untuk menjelaskan rencana diet harian dan jenis makanan yang perlu dihindari."

Komunikasi yang efektif antara perawat dan ahli gizi berperan penting dalam memastikan keberhasilan terapi nutrisi, meningkatkan kepatuhan pasien, serta mendukung proses penyembuhan secara optimal.

3. Tujuan Komunikasi Perawat dan Ahli Gizi

Tujuan komunikasi antara perawat dan ahli gizi meliputi:

a. Koordinasi Perawatan Nutrisi

Memastikan seluruh tim kesehatan memiliki pemahaman yang sama terkait rencana diet dan kebutuhan nutrisi pasien.

b. Pendidikan Pasien

Memberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya nutrisi dalam proses penyembuhan serta cara menjalankan diet yang dianjurkan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Nutrisi

Mengumpulkan dan melaporkan data terkait asupan nutrisi serta respons pasien terhadap diet yang diberikan.

d. Peningkatan Keselamatan Pasien

Mengidentifikasi dan melaporkan masalah nutrisi seperti alergi, intoleransi makanan, atau ketidakseimbangan nutrisi.

e. Optimalisasi Status Nutrisi

Mendukung pencapaian kondisi nutrisi yang optimal untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

4. Tantangan dalam Komunikasi Perawat dan Ahli Gizi

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam komunikasi interprofesional antara perawat dan ahli gizi antara lain:

a. Perbedaan Terminologi Profesional

Perbedaan istilah dalam menjelaskan kondisi nutrisi atau rencana diet dapat menimbulkan kesalahpahaman.

b. Keterbatasan Waktu

Tingginya beban kerja membatasi kesempatan untuk melakukan komunikasi yang mendalam.

c. Kurangnya Pemahaman Peran

Kurangnya pemahaman terhadap peran masing-masing profesi dapat menghambat kerja sama.

d. Keterbatasan Sistem Informasi

Kurangnya integrasi sistem dokumentasi dapat menghambat pertukaran informasi nutrisi secara efektif.

5. Strategi Peningkatan Komunikasi Perawat dan Ahli Gizi

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi, dapat dilakukan strategi berikut:

a. Pelatihan Interprofesional

Mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman peran masing-masing profesi.

b. Rapat Tim Secara Berkala

Melakukan diskusi rutin terkait perkembangan pasien dan masalah nutrisi untuk meningkatkan koordinasi tim.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Kesehatan

Menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk mempermudah akses dan pertukaran informasi nutrisi pasien.

d. Penerapan Komunikasi Terstruktur

Menggunakan pendekatan seperti SBAR dalam menyampaikan informasi terkait kondisi nutrisi pasien.

e. Penguatan Hubungan Kolaboratif

Membangun hubungan profesional yang saling percaya dan menghargai untuk meningkatkan efektivitas kerja tim.

H. Perilaku Disruptif dalam Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan

Perilaku disruptif (disruptive behaviors) menurut Berman et al., (2021), merupakan salah satu faktor utama yang menghambat komunikasi efektif dalam tim kesehatan. Tiga bentuk perilaku disruptif yang paling sering dilaporkan dalam praktik keperawatan adalah incivility (ketidaksopanan), kekerasan horizontal (lateral violence), dan bullying (perundungan).

1. Incivility (Ketidaksopanan)

Incivility didefinisikan sebagai perilaku tidak sopan atau mengganggu yang dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun fisiologis bagi individu yang terlibat. Apabila tidak ditangani dengan baik, perilaku ini berpotensi berkembang menjadi situasi yang lebih serius dan mengancam.

Perilaku incivility berada dalam suatu spektrum, mulai dari tindakan yang tampak ringan hingga perilaku yang lebih serius. Pada tingkat ringan, perilaku ini dapat berupa sikap yang mengganggu seperti: ekspresi nonverbal negatif (misalnya memutar mata), komentar sarkastik, sikap meremehkan yang sering dianggap sebagai "hal biasa" atau dimaklumi karena kondisi emosional individu.

Namun, pada tingkat yang lebih berat, incivility dapat berkembang menjadi perilaku yang bersifat mengintimidasi dan berpotensi membahayakan, seperti: menahan informasi penting terkait pasien, mengintimidasi rekan kerja, atau memberikan ancaman, termasuk ancaman fisik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa incivility di tempat kerja berkaitan erat dengan dampak negatif terhadap kesehatan tenaga kesehatan, seperti kelelahan emosional (emotional exhaustion). Selain itu, perilaku ini juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja, antara lain: meningkatnya absensi, menurunnya komitmen terhadap organisasi, berkurangnya motivasi kerja, menurunnya kualitas komunikasi, berkurangnya pelaporan masalah, serta meningkatnya kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan.

Perilaku incivility beserta dampaknya dapat merusak iklim organisasi yang ideal, yaitu lingkungan kerja yang didasarkan pada rasa saling menghargai. Oleh

karena itu, penting bagi perawat untuk menjunjung tinggi nilai kesopanan dan profesionalisme dalam setiap interaksi. Meskipun menjaga sikap sopan dan menghormati orang lain tidak selalu mudah, terutama dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, hal ini tetap merupakan tanggung jawab profesional. Sikap civility menuntut keberanian, kepedulian terhadap orang lain, kehadiran secara penuh dalam interaksi, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi.

2. Lateral Violence (Kekerasan Horizontal)

Lateral violence, yang juga dikenal sebagai horizontal violence atau horizontal hostility, merupakan bentuk perilaku agresif yang terjadi antar tenaga keperawatan pada tingkat hierarki yang sama. Perilaku ini dapat berupa kekerasan verbal, emosional, maupun nonverbal, meskipun jarang berbentuk kekerasan fisik.

Manifestasi lateral violence umumnya berupa perilaku tidak langsung (covert behavior) yang dapat merusak hubungan kerja dan komunikasi tim. Contoh perilaku tersebut meliputi: menyebarkan gosip, kekerasan verbal yang bertujuan memperlakukan, menahan informasi penting, komentar sinis atau merendahkan, respons yang kasar atau tidak profesional, sabotase pekerjaan, menjadikan individu tertentu sebagai kambing hitam (scapegoating), tidak memberikan bantuan saat dibutuhkan, membicarakan individu lain secara negatif, pengucilan (ostracism), serta pelanggaran privasi rekan kerja.

Literatur menunjukkan bahwa lateral violence merupakan fenomena yang cukup luas, dengan prevalensi mencapai 65% hingga 80% di kalangan perawat. Kelompok yang paling rentan terhadap perilaku ini adalah mahasiswa keperawatan selama praktik klinik dan perawat baru (new graduate nurses). Apabila tidak ditangani secara tepat, lateral violence dapat berdampak serius, antara lain: meningkatnya keinginan untuk meninggalkan profesi, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, penurunan kinerja kerja, peningkatan absensi, serta tingginya tingkat turnover tenaga keperawatan. Secara ekonomi, kerugian akibat lateral violence diperkirakan mencapai 30.000 hingga 100.000 dolar per individu per tahun, yang berasal dari biaya absensi, penurunan produktivitas, serta kebutuhan perawatan kesehatan.

3. Bullying (Perundungan di Tempat Kerja)

Bullying di tempat kerja didefinisikan sebagai tindakan berulang yang tidak wajar, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pekerja lain, dengan tujuan untuk mengintimidasi, merendahkan, memperlakukan, atau melemahkan individu tersebut, serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

Pelaku bullying umumnya berada pada posisi yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, baik secara nyata maupun persepsi. Perilaku ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja.

Karakteristik utama bullying meliputi: terjadi secara berulang, bersifat sistematis dan terarah pada individu tertentu, menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang signifikan. Dampak bullying dalam lingkungan kerja kesehatan antara lain: gangguan kesehatan fisik dan mental pada korban, terciptanya lingkungan kerja yang tidak kondusif,

terganggunya komunikasi dan kolaborasi tim, serta meningkatnya angka keluar kerja (turnover) perawat. Dengan demikian, bullying tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

4. Respons terhadap Perilaku Disruptif

Berbagai organisasi keperawatan telah menekankan pentingnya penanganan perilaku disruptif karena dampaknya yang signifikan terhadap tenaga kesehatan dan keselamatan pasien. Perilaku seperti incivility, lateral violence, dan bullying harus diidentifikasi dan ditangani secara sistematis melalui kebijakan organisasi dan penguatan budaya kerja yang sehat (Berman et al., 2021).

Sebagai contoh, *American Association of Critical-Care Nurses* (AACN) mengembangkan standar nasional untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang sehat. Salah satu standar utama adalah komunikasi yang terampil (*skilled communication*), yang menekankan bahwa perawat harus memiliki kompetensi komunikasi yang setara dengan keterampilan klinisnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi bukan hanya keterampilan pendukung, tetapi merupakan kompetensi inti dalam praktik keperawatan profesional (Berman et al., 2021).

I. Evidence-Based Practice: Persepsi Hubungan Perawat–Dokter pada Unit Medikal Bedah dan ICU

Kolaborasi yang efektif antara perawat dan dokter merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Namun, secara historis, hubungan antara perawat dan dokter belum sepenuhnya berada pada posisi yang setara, sehingga masih diperlukan upaya untuk memperkuat kemitraan profesional yang lebih seimbang.

Menurut penelitian Johnson dan Kring (2012), beberapa hambatan utama dalam kolaborasi perawat–dokter meliputi ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*), jarak profesional (*professional distance*), serta komunikasi yang tidak

efektif. Selain itu, faktor spesialisasi klinis juga diduga memengaruhi dinamika hubungan tersebut, karena setiap unit pelayanan memiliki kebutuhan interaksi yang berbeda.

Untuk mengeksplorasi hal tersebut, dilakukan penelitian dengan desain kuasi-eksperimental yang melibatkan 170 perawat, terdiri dari 54% perawat medikal bedah dan 46% perawat ICU. Sebagian besar responden merupakan perawat pelaksana (direct-care nurses), dan 93% bekerja secara penuh waktu. Perbedaan karakteristik yang signifikan hanya ditemukan pada tingkat pendidikan, di mana perawat ICU lebih banyak memiliki gelar sarjana dibandingkan perawat medikal bedah.

Penelitian ini menggunakan kuesioner berisi 25 item yang mengevaluasi: tingkat kolaborasi antara perawat dan dokter, profesionalisme dan perilaku disruptif, serta dukungan manajerial dan administratif.

Hasil Penelitian

Secara umum, baik perawat ICU maupun medikal bedah menyatakan kepuasan terhadap hubungan kerja antara perawat dan dokter. Kedua kelompok juga menilai bahwa dokter menghargai keputusan klinis perawat.

Namun demikian, beberapa temuan penting menunjukkan adanya tantangan dalam hubungan tersebut, yaitu: Sebagian besar perawat pernah menyaksikan perilaku disruptif dari dokter, tetapi hanya sebagian kecil yang melaporkannya. Perawat ICU cenderung lebih berani melaporkan perilaku tidak profesional dibandingkan perawat medikal bedah.

Mayoritas perawat masih memandang diri mereka berada pada posisi subordinat terhadap dokter. Sekitar setengah dari responden berpendapat bahwa dokter belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab perawat. Dalam interaksi sehari-hari, dokter lebih sering memanggil perawat dengan nama depan, sedangkan perawat jarang melakukan hal yang sama kepada dokter, yang mencerminkan adanya perbedaan relasi sosial-profesional.

Implikasi terhadap Praktik Keperawatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum hubungan perawat–dokter dinilai baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kolaborasi interprofesional.

Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian antara lain:

Rendahnya pelaporan terhadap perilaku disruptif, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem yang ada.

Persepsi subordinasi perawat terhadap dokter yang dapat menghambat komunikasi terbuka dan pengambilan keputusan kolaboratif. Kurangnya

pemahaman dokter terhadap peran dan tanggung jawab perawat, yang berpotensi menurunkan efektivitas kerja tim.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi yang dapat meningkatkan hubungan kolegal antara perawat dan dokter, seperti: pengembangan program mentoring interprofesional, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bersama, serta penguatan budaya kerja yang berbasis saling menghargai dan kolaboratif. Hubungan yang positif, setara, dan saling menghormati antara perawat dan dokter merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan hubungan interprofesional harus menjadi bagian integral dalam praktik dan pendidikan keperawatan.

Perilaku disruptif dalam lingkungan pelayanan kesehatan memerlukan intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penanganan harus dilakukan pada berbagai tingkat, yaitu individu, organisasi (manajerial), serta pendidikan keperawatan. Tujuan utama dari intervensi ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, aman secara emosional, serta mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan pasien.

1. Tingkat Individu

Pada tingkat individu, setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang profesional dan menghormati rekan kerja. Upaya yang dapat dilakukan meliputi: Menunjukkan sikap saling menghargai dalam setiap interaksi profesional. Meningkatkan kesadaran terhadap perilaku disruptif, baik pada diri sendiri maupun orang lain, Mengembangkan keterampilan komunikasi untuk mampu mengidentifikasi dan mengatasi perilaku disruptif secara konstruktif, Kesadaran dan kompetensi individu menjadi fondasi utama dalam menciptakan budaya komunikasi yang sehat.

2. Tingkat Manajerial/Organisasi

Pada tingkat organisasi, diperlukan kebijakan dan sistem yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

Menyusun kebijakan organisasi yang menegaskan prinsip zero tolerance terhadap perilaku disruptif, Menetapkan definisi yang jelas mengenai bentuk perilaku yang tidak dapat diterima. Mengembangkan lingkungan kerja yang aman secara emosional (emotionally safe work environment), Menyusun dan menerapkan kode etik serta kode perilaku profesional secara konsisten. Melakukan intervensi secara tegas dan tepat ketika terjadi perilaku disruptif, Melakukan evaluasi budaya kerja untuk mengidentifikasi keberadaan perilaku disruptif, Menunjukkan keteladanan dalam perilaku profesional dan etis oleh

pimpinan , Peran kepemimpinan sangat penting dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung komunikasi yang sehat dan kolaboratif.

3. Tingkat Pendidikan Keperawatan dan Pengembangan Profesional

Institusi pendidikan dan program pengembangan profesional memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi komunikasi sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan meliputi: Mengembangkan kurikulum yang memuat materi tentang perilaku disruptif, termasuk dampak dan cara penanganannya , Memberikan pelatihan manajemen konflik kepada mahasiswa dan tenaga kesehatan, Menyelenggarakan program edukasi berkelanjutan mengenai strategi mengenali dan mengatasi perilaku disruptif , Pendidikan yang terstruktur akan membekali perawat dengan kemampuan menghadapi dinamika komunikasi dalam praktik klinik secara profesional.

4. Tujuan Intervensi

Intervensi terhadap perilaku disruptif pada berbagai tingkat bertujuan untuk:

Menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati ,

- a. Meningkatkan keselamatan pasien (patient safety)
- b. Memperkuat kerja sama tim interprofesional
- c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan
- d. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan

J. Hambatan dalam Komunikasi Antarprofesi dalam Tim Kesehatan

1. Konsep Hambatan Komunikasi Antarprofesi

Komunikasi yang efektif merupakan prasyarat utama dalam kolaborasi tim kesehatan. Namun, dalam praktik pelayanan, berbagai hambatan sering muncul dan berpotensi mengganggu proses komunikasi antarprofesi. Hambatan ini dapat berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan, terganggunya koordinasi tim, serta meningkatnya risiko terhadap keselamatan pasien.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai faktor penghambat komunikasi menjadi penting sebagai dasar dalam merancang strategi peningkatan kolaborasi interprofesional.

2. Jenis Hambatan dalam Komunikasi Antarprofesi

a. Perbedaan Terminologi Profesional

Setiap profesi kesehatan memiliki terminologi dan istilah teknis yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disertai dengan klarifikasi yang memadai, sehingga berpotensi mengganggu akurasi pertukaran informasi.

b. Keterbatasan Waktu

Lingkungan pelayanan kesehatan yang dinamis dan beban kerja yang tinggi seringkali membatasi waktu yang tersedia untuk komunikasi yang efektif. Kondisi ini dapat menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan secara lengkap atau tidak dipahami secara optimal oleh anggota tim.

c. Kurangnya Pemahaman terhadap Peran dan Tanggung Jawab

Ketidakjelasan mengenai peran dan fungsi masing-masing profesi dapat menghambat proses kolaborasi. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan duplikasi tindakan, konflik peran, atau bahkan pengabaian terhadap kontribusi profesi tertentu.

d. Kesalahan Interpretasi Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh, memiliki makna yang dapat ditafsirkan secara berbeda oleh individu. Misinterpretasi terhadap sinyal nonverbal dapat memicu kesalahpahaman, konflik, serta menurunkan kualitas hubungan kerja dalam tim.

e. Sikap Individu dan Budaya Kerja

Sikap negatif, kurangnya rasa saling menghargai, serta budaya kerja yang tidak mendukung kolaborasi (misalnya budaya hierarki yang kaku) dapat menjadi hambatan utama dalam komunikasi antarprofesi. Kondisi ini dapat mengurangi keterbukaan, partisipasi aktif, dan kepercayaan antar anggota tim.

f. Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk mendukung komunikasi yang cepat dan akurat. Namun, keterbatasan sistem, gangguan teknis, atau kurangnya kompetensi dalam penggunaan teknologi dapat menghambat aliran informasi dan koordinasi tim.

3. Implikasi Hambatan Komunikasi

Hambatan dalam komunikasi antarprofesi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- a. Penurunan kualitas pelayanan kesehatan
- b. Terjadinya kesalahan medis (*medical error*)
- c. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan klinis
- d. Menurunnya kepuasan pasien dan tenaga kesehatan
- e. Terganggunya keselamatan pasien (*patient safety*)

4. Strategi Mengatasi Hambatan Komunikasi Antarprofesi

Upaya mengatasi hambatan komunikasi antarprofesi dalam pelayanan kesehatan memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga mencakup penguatan sistem, budaya organisasi, serta penggunaan

teknologi yang mendukung komunikasi efektif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

a. Pelatihan Interprofesional

Pelatihan interprofesional merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antar tenaga kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing profesi
- 2) Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif
- 3) Meningkatkan kemampuan kerja tim dan kolaborasi

Pelatihan dapat dilakukan melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, maupun pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*).

b. Rapat Tim Secara Berkala

Penyelenggaraan rapat tim secara rutin (misalnya *case conference* atau *clinical meeting*) sangat penting untuk:

- 1) Membahas perkembangan kondisi pasien
- 2) Mengidentifikasi masalah yang muncul
- 3) Menyusun rencana perawatan secara bersama

Rapat tim memberikan kesempatan bagi seluruh anggota tim untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan klinis serta memperkuat koordinasi antarprofesi.

c. Penerapan Metode Komunikasi Terstandarisasi

Penggunaan metode komunikasi yang terstruktur, seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), dapat meningkatkan kejelasan, ketepatan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi klinis.

Penerapan metode ini membantu:

- 1) Mengurangi ambiguitas komunikasi
- 2) Mempercepat pengambilan keputusan
- 3) Meningkatkan keselamatan pasien

Standarisasi komunikasi juga mempermudah koordinasi dalam situasi darurat maupun kondisi klinis yang kompleks.

d. Penguatan Hubungan Interpersonal dan Budaya Kolaboratif

Membangun hubungan kerja yang positif antar anggota tim merupakan faktor penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan budaya saling menghargai dan terbuka
- 2) Peningkatan kepercayaan antarprofesi
- 3) Pengurangan hambatan hierarki yang berlebihan

Lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

e. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Secara Optimal

Penggunaan teknologi informasi kesehatan, seperti rekam medis elektronik (*electronic health record*), aplikasi komunikasi klinis, dan sistem informasi terintegrasi, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pertukaran informasi.

Agar optimal, diperlukan:

- 1) Pelatihan bagi seluruh anggota tim dalam penggunaan teknologi
- 2) Standarisasi sistem dokumentasi dan komunikasi digital
- 3) Akses yang merata terhadap sistem informasi

Pemanfaatan teknologi yang efektif akan mempercepat aliran informasi, meningkatkan koordinasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data

K. Prinsip Komunikasi dalam Kasus Pemicu pada Pelayanan Multidisiplin

1. Konsep Kasus Pemicu dalam Komunikasi Multidisiplin

Dalam pelayanan kesehatan multidisiplin, *kasus pemicu* merujuk pada kondisi atau peristiwa klinis tertentu yang menuntut keterlibatan berbagai profesi kesehatan secara simultan. Situasi ini biasanya ditandai dengan kompleksitas masalah pasien, perubahan kondisi yang signifikan, atau kebutuhan intervensi lintas disiplin secara cepat dan terkoordinasi.

Kasus pemicu menjadi titik awal terjadinya komunikasi intensif antar anggota tim kesehatan, karena diperlukan integrasi informasi, koordinasi tindakan, serta pengambilan keputusan bersama untuk mencapai hasil klinis yang optimal. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, terstruktur, dan responsif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pelayanan yang holistik dan berpusat pada pasien.

2. Prinsip Komunikasi dalam Kasus Pemicu

Beberapa prinsip utama dalam komunikasi multidisiplin terkait kasus pemicu meliputi:

a. Komunikasi Terbuka dan Jelas

Setiap anggota tim harus menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan langsung terkait kondisi pasien. Hal ini mencakup pelaporan data klinis, perubahan kondisi pasien, serta hasil intervensi secara tepat waktu untuk menghindari miskomunikasi.

b. Pendekatan Berbasis Tim (Team-Based Approach)

Komunikasi dalam kasus pemicu harus mengedepankan pendekatan kolaboratif, di mana setiap profesi memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan klinis.

c. Pemilihan Saluran Komunikasi yang Efektif

Penggunaan media komunikasi yang tepat sangat penting untuk menjamin kelancaran koordinasi tim, seperti:

- 1) Pertemuan tatap muka (case conference)
- 2) Komunikasi langsung (bedside communication)
- 3) Sistem elektronik (electronic health record)
- 4) Telekomunikasi (teleconference)

Akses yang merata terhadap saluran komunikasi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi.

d. Mendengarkan Secara Empatik

Kemampuan mendengarkan secara aktif dan empatik memungkinkan anggota tim memahami perspektif profesi lain serta kompleksitas kondisi pasien. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan tepat.

e. Menghargai Peran dan Kompetensi Profesi Lain

Pengakuan terhadap peran, tanggung jawab, dan keahlian masing-masing profesi merupakan dasar dalam membangun kolaborasi yang efektif. Sikap saling menghormati akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas interaksi tim.

f. Dokumentasi yang Akurat dan Berkelanjutan

Pencatatan yang lengkap, sistematis, dan terkini sangat penting dalam mendukung komunikasi tim. Dokumentasi yang baik memungkinkan seluruh anggota tim memahami kondisi pasien, rencana perawatan, serta perkembangan klinis secara menyeluruh.

3. Contoh Kasus Pemicu dalam Pelayanan Multidisiplin

Kasus: Penanganan Pasien dengan Kondisi Klinis Kompleks

Seorang pasien dengan penyakit serius dan kondisi klinis kompleks memerlukan perawatan yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kasus ini, beberapa pemicu yang mendorong komunikasi dan kolaborasi intensif antara lain:

a. Rujukan Pasien

Saat pasien dirujuk, informasi awal mengenai kondisi klinis, riwayat penyakit, dan intervensi sebelumnya harus disampaikan secara lengkap dan akurat kepada tim penerima. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan perawatan lanjutan.

b. Pertemuan Tim (Case Conference)

Setelah pasien diterima, tim kesehatan melakukan diskusi bersama untuk:

- 1) Menganalisis kondisi pasien
- 2) Menetapkan diagnosis kerja
- 3) Menyusun rencana perawatan terpadu

Pertemuan ini melibatkan seluruh profesi terkait dan menjadi wadah utama koordinasi tim.

c. Komunikasi Real-Time

Selama proses perawatan, komunikasi harus berlangsung secara cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien. Misalnya:

- 1) Perawat melaporkan perubahan tanda vital
- 2) Dokter memberikan instruksi klinis segera
- 3) Terapis menyesuaikan intervensi

d. Berbagi Informasi dan Kolaborasi Terintegrasi

Penggunaan sistem rekam medis elektronik memungkinkan seluruh anggota tim mengakses informasi pasien secara bersamaan. Hal ini mendukung:

- 1) Koordinasi tindakan
- 2) Sinkronisasi jadwal intervensi
- 3) Konsistensi rencana perawatan

e. Diskusi Kasus Secara Berkala

Tim kesehatan melakukan evaluasi rutin melalui diskusi kasus untuk:

- a. Menilai perkembangan pasien
- b. Mengidentifikasi masalah baru
- c. Menyesuaikan rencana perawatan

Diskusi ini juga menjadi sarana pembelajaran tim dan peningkatan kualitas pelayanan.

4. Aktivitas Belajar Testruktur

a. Aktivitas 1: Simulasi komunikasi interprofessional menggunakan pendekata SBAR

kasus

Seorang pasien laki-laki, 65 tahun, dirawat di ruang ICU dengan diagnosis stroke iskemik. Pasien mengalami penurunan kesadaran, disfagia, dan tekanan darah tidak stabil. Perawat menemukan: saturasi O₂ menurun menjadi 88% , pasien sulit menelan , terdapat risiko aspirasi. Tim yang terlibat: dokter , perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker

Tugas Mahasiswa

- 1) Lakukan komunikasi menggunakan SBAR kepada dokter
- 2) Identifikasi kebutuhan kolaborasi interprofesional

3) Jelaskan tindakan yang harus dilakukan masing-masing profesi

Jawaban/Expected Answer

1. SBAR

S: "Saya perawat di ICU, melaporkan pasien stroke dengan penurunan saturasi 88%"

B: "Pasien dirawat dengan stroke iskemik, mengalami disfagia"

A: "Saat ini pasien mengalami penurunan oksigenasi dan risiko aspirasi"

R: "Mohon evaluasi segera, kemungkinan pemberian oksigen tambahan dan NGT feeding"

5. Kolaborasi Tim

Dokter → evaluasi medis

Perawat → monitoring dan intervensi awal

Ahli gizi → diet enteral

Fisioterapis → terapi mobilisasi

Apoteker → evaluasi obat

6. Tujuan Kolaborasi

- a. Mencegah aspirasi
- b. Menstabilkan kondisi pasien
- c. Meningkatkan pemulihan

Rubrik Penilaian (RB-06)

Rubrik Komunikasi Interprofesional & Eskalasi (CPMK-6)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kejelasan Pesan Klinis	Pesan tidak jelas; kolaborasi tidak terjadi.	Pesan cukup; kolaborasi terbatas.	Pesan jelas; kolaborasi efektif.	Pesan sangat jelas; kolaborasi proaktif.
Ketepatan Eskalasi	Tidak eskalasi atau keliru.	Eskalasi ada namun kurang runtut.	Eskalasi runtut; fokus risiko jelas.	Eskalasi sangat runtut; fokus tajam + konfirmasi.

Aktivitas 2: Simulasi Komunikasi Interprofesional Berbasis Keselamatan Pasien (ISBAR & TBaK)

Kasus:

Seorang pasien perempuan (Ny. S), 72 tahun, dirawat di Bangsal Jantung dengan diagnosa Gagal Jantung Kongestif (CHF). Pasien tiba-tiba mengeluh sesak napas berat saat sedang makan siang. Perawat melakukan pemeriksaan cepat dan menemukan:

- TD: 160/100 mmHg, Nadi: 110x/menit, RR: 32x/menit, Saturasi O₂: 85% dengan *nasal cannula*.
- Terdapat suara ronkhi di basal paru.
- Pasien tampak gelisah dan menggunakan otot bantu napas.
- Keluarga pasien panik di samping tempat tidur.

Tim yang Terlibat: Perawat Jaga, Dokter Spesialis Jantung (via telepon), Ahli Gizi, dan Apoteker Klinik.

Tugas Mahasiswa:

1. Lakukan pelaporan kondisi kritis kepada dokter menggunakan kerangka ISBAR.
2. Terapkan teknik TBaK saat menerima instruksi verbal/telepon dari dokter untuk memastikan akurasi pesan (mencegah *error*).
3. Identifikasi peran kolaboratif masing-masing profesi untuk menangani kegawatan ini.

Jawaban (*Expected Answer*)

1. Komunikasi ISBAR (Laporan Perawat ke Dokter)

- I (Identification): "Selamat siang Dokter, saya Perawat B dari Bangsal Jantung RS Pelita. Saya melaporkan kondisi Ny. S di bed 04."

- S (Situation): "Kondisi pasien saat ini mengalami sesak napas akut secara tiba-tiba. Saturasi oksigen turun menjadi 85% dan RR meningkat hingga 32x/menit."
- B (Background): "Pasien masuk dengan CHF, mendapatkan terapi diuretik rutin. Sebelumnya kondisi stabil, namun sesak terjadi setelah makan siang."
- A (Assessment): "Saya menilai pasien mengalami edema paru akut dan gagal napas tipe 1. Ada risiko henti napas jika tidak segera ditangani."
- R (Recommendation): "Saya merekomendasikan penggantian oksigen ke *Non-Rebreathing Mask* (NRM) 12 lpm dan mohon instruksi untuk tambahan dosis diuretik atau pemeriksaan rontgen cito."

2. Teknik TBaK (Menerima Instruksi Dokter)

- T (Tulis): Perawat menuliskan instruksi dokter di catatan perkembangan pasien (CPPT): "*Berikan Furosemide 40mg IV cito, pasang NRM 12 lpm.*"
- Ba (Baca): Perawat membacakan kembali: "Baik Dok, saya ulangi instruksinya: Berikan Furosemide dosis empat puluh miligram melalui intra vena secara cito, dan pasang oksigen NRM dua belas liter per menit. Benar demikian, Dok?"
- K (Konfirmasi): Dokter mengonfirmasi: "Ya, benar." (Perawat memberikan stempel/tanda TBaK untuk verifikasi dokter dalam 24 jam).

3. Kolaborasi Tim & Tindakan

- Dokter: Evaluasi medis segera, penentuan dosis obat darurat, dan instruksi penunjang (Laboratorium/Radiologi).
- Perawat: Stabilisasi oksigenasi, pemberian obat sesuai instruksi (TBaK), dan monitoring ketat TTV.
- Apoteker: Menyiapkan obat darurat dan memastikan tidak ada interaksi obat yang membahayakan pada kondisi akut.
- Ahli Gizi: Mengevaluasi tekstur makanan atau pembatasan cairan pasca-krisis untuk mencegah beban kerja jantung berlebih.

Tujuan Kolaborasi:

1. Mencegah Gagal Napas: Intervensi oksigenasi cepat melalui koordinasi yang runtut.
2. Akurasi Terapi: Menghindari kesalahan pemberian obat melalui teknik TBaK (*Read-back/Closed-loop*).
3. Keselamatan Pasien: Memastikan eskalasi risiko dilakukan tepat waktu sebelum kondisi memburuk.

Rubrik Penilaian (RB-06)

Rubrik Komunikasi Interprofesional & Eskalasi (CPMK-6)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kejelasan Pesan Klinis	Pesan tidak jelas; struktur ISBAR tidak tampak; kolaborasi gagal.	Struktur ISBAR ada namun tidak lengkap; pesan kurang fokus pada risiko.	Pesan jelas; menggunakan struktur ISBAR secara runtut; kolaborasi efektif.	Pesan sangat jelas; proaktif dalam kolaborasi; menggunakan terminologi medis yang tepat.
Ketepatan Eskalasi & TBaK	Tidak melakukan eskalasi atau salah melakukan teknik TBaK.	Eskalasi dilakukan tetapi tidak runtut; teknik TBaK tidak dilakukan secara utuh (misal: tidak baca ulang).	Eskalasi runtut; fokus risiko jelas; melakukan TBaK dengan benar.	Eskalasi sangat runtut; fokus risiko tajam; konfirmasi TBaK dilakukan secara konsisten dan tegas.

L. Ringkasan

- **Komunikasi Interprofesional sebagai Pilar Keselamatan:** Komunikasi interprofesional bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan komponen kunci dan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berfokus pada pasien (*Patient-Centered Care*).
- **Prinsip Kolaborasi Efektif:** Kolaborasi yang berhasil menuntut adanya komunikasi yang jelas, terstruktur, serta sikap saling menghormati (*mutual respect*) antarprofesi untuk menghilangkan hierarki yang menghambat pertukaran data klinis.
- **Standardisasi Komunikasi (SBAR, ISBAR, & TBaK):** Penggunaan model komunikasi terstruktur seperti **SBAR** (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), **ISBAR** (dengan tambahan *Identification*), dan teknik **TBaK** (*Tulis, Baca, Konfirmasi*) sangat krusial untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan kesalahan prosedur (*medical error*) dalam situasi kritis.
- **Budaya Kolaboratif dan Mitigasi Perilaku:** Penguatan budaya kerja sama tim dan pengelolaan perilaku disruptif (seperti komunikasi yang tidak sopan atau meremehkan) merupakan strategi penting dalam menjaga psikologis tim dan meningkatkan derajat keselamatan pasien di berbagai *setting* layanan.

- **Peran Strategis Perawat:** Perawat memiliki posisi sentral sebagai **koordinator/manajer** komunikasi dalam tim kesehatan, yang bertugas menyelaraskan berbagai rencana asuhan dari disiplin ilmu berbeda agar tercipta koordinasi layanan yang efektif dan berkesinambungan.
- **Eskalasi Risiko:** Kemampuan melakukan eskalasi secara runtut dan tepat waktu kepada anggota tim lain merupakan kompetensi inti untuk memastikan setiap perubahan kondisi pasien yang signifikan mendapatkan respons klinis yang cepat dan akurat

M. Daftar Pustaka

- Alfarizi, M., & Nuryana, A. (2019). *Komunikasi Efektif Interprofesi Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit*. 2.
- Berman, A., Snyder, J. S., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing Concepts, Process, and Practice. Eleventh Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Faizin, F. Z., Ulinuha, L., Huda, N., & Uswiyah, N. (2025). Keterampilan Komunikasi Efektif Dan Kerja Tim Perawat Dengan Inter Profesional. *Jurnal Kesehatan Ilkmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific)*, 10(1).
- Keumalasari, Yetti, K., & Hariyati, R. T. S. (2021). *Penerapan Model Kolaborasi Interprofesional dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan Pasien: a Systematic Review*. 4(2).
- Murdiany, N. A., Pertiwiwati, E., & Setiawan, H. (2021). *Journal of Nursing Invention*. 2(1).
- Noviyanti, A., Sari, N. L., Lestari, T., Mitra, S., Karanganyar, H., Brigjen, J. L., Barat, K., Indah, G. P., Tasikmadu, K., Karanganyar, K., & Tengah, J. (2023). *Komunikasi Efektif Dalam Pelaksanaan Interprofessional Kolaborasi Di Rumah Sakit*. 3(1), 1–12.
- Nur, H. A., & Santoso, A. (2018). *Komunikasi Interprofesional Dalam Peningkatan Keselamatan Pasien : Systematic Review*. 1(1).
- Pertiwi, M. R., Annalia, W., Raziansyah, Lucia, F., Annisa, F., Yohana, S., Dely, M., Widya, A., Ikhsan, F., & Arniati. (2022). *Komunikasi terapeutik dalam kesehatan*.
- Rokhmah, N. A., Diponegoro, U., & Indonesia, S. (2017). *Komunikasi efektif dalam praktek kolaborasi interprofesi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan*. 1(1), 65–71.

Sarfika, R. (2025). *Buku ajar komunikasi dasar keperawatan*. Padang : Andalas University Press.

PROFIL PENULIS



Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1976. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan (1997) di PAM Keperawatan Dep Kes Semarang, S1 Keperawatan (2002) dan Program Profesi Ners (2004) di PSIK FK Universitas Airlangga Surabaya, S2 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (2013).

Penulis aktif sebagai dosen tetap Keperawatan di FIKES Univ. Muh. Magelang sejak tahun 2003 dan FHS Univ. Horizon Indonesia Karawang sejak tahun 2025, mengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, Pemenuhan Kebutuhan Manusia, Promosi Kesehatan, Keperawatan Kritis, Keperawatan Bencana serta Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik. Pengalaman organisasi penulis aktif di organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI), serta aktif di DPD PPNI Kabupaten Karawang sebagai anggota. Motto hidup yakni "MAJU TERUS PANTANG MUNDUR-BISMILLAH KITA BISA."



Erna Juliana Simatupang, S.Kep., SST., MKM Lahir di Limapuluh, 09 Juli 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011. Menyelesaikan pendidikan D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Kebidanan, STIKes Bina Permata Medika tahun 2012 dan S1 Keperawatan pada STIKes Medistra pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan: menjadi dosen sejak tahun 2001 sampai sekarang. Tahun 2001-2003 dosen di Akademi Keperawatan Prima Medan, Tahun 2003-2004 menjadi Direktur di Akademi Kebidanan

Dharma Husada Batam, Tahun 2004-2008 menjadi Direktur di Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang, Tahun 2008-2012 menjadi Wakil Ketua I Bidang Akademi di Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang, Tahun 2012-2018 menjadi Wakil Ketua I Bidang Akademi di STIKes Bina Permata Medika Tangerang, Tahun 2018-2019 menjadi Pjs. Ketua STIKes Tarumanagara Jakarta, tahun 2019-2023, menjadi Ketua Penjamin Mutu di Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang, tahun 2023- sekarang menjadi Ketua STIKes Mayapada. Saat ini penulis bekerja di STIKes Mayapada dan mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Organisasi dan Manajemen, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Perilaku Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan berbagai pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernajuliana50@gmail.com

Motto: "Teruslah belajar mencari ilmu, sebab kita akan pergi menjelajahi pengetahuan yang sangat luas. Dalam perjalanan mencari ilmu, semakin kita mencari, semakin banyak yang belum kita ketahui, sehingga kita sungguh menyadari bahwa kita semakin kecil dan betapa besar DIA, SANG MAHA MENGETAHUI. Akhirnya, yang paling berharga adalah mencari ilmu agar kita dapat berbagi ilmu, bermanfaat dan berarti bagi sesama. Hidup bukan karena Hari, Hidup hanya karena ARTI" (opsional jika ingin ditambahkan)

PROFIL PENULIS



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis yang akrab dipanggil Willy ini lahir di Malaka-NTT, 27 Mei 1972. Memiliki Riwayat Pendidikan: Akper PEMDA Kupang, tamat tahun 1996, Ners Unair tamat tahun 2004, S2 Keperawatan Unair, tamat tahun 2010, S3 Keperawatan UI, tamat tahun 2023. Penulis sebagai staf dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Kupang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, aktif mengikuti seminar, pertemuan nasional/internasional. Riwayat organisasi: sebagai Ketua DPW PPNI

Provinsi NTT, Anggota Bidang Diklat DPP PPNI, Anggota Kolegium Keperawatan Indonesia.

Email Penulis: aemilianusmau58@gmail.com

Sinopsis

Buku ajar Komunikasi Keperawatan membahas konsep, prinsip, dan penerapan komunikasi dalam praktik keperawatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami pentingnya komunikasi sebagai bagian utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif, profesional, dan berpusat pada pasien.

Isi buku ini mencakup pengertian dan tujuan komunikasi, unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, prinsip komunikasi efektif, komunikasi terapeutik, teknik mendengarkan aktif, empati, sikap caring, serta penerapan komunikasi dalam hubungan perawat dengan pasien, keluarga, kelompok, dan tim kesehatan. Buku ini juga membahas hambatan komunikasi, etika dalam berkomunikasi, serta strategi komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus, seperti pasien anak, lansia, pasien dengan gangguan pendengaran, pasien cemas, pasien marah, maupun pasien dalam kondisi kritis.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa komunikasi bukan hanya proses menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan keterampilan profesional yang membutuhkan kepekaan, kesabaran, empati, dan tanggung jawab. Komunikasi yang baik dapat membantu perawat menggali keluhan pasien, memberikan edukasi kesehatan, membangun rasa aman, serta meningkatkan kualitas hubungan terapeutik antara perawat dan pasien.

Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ajar Komunikasi Keperawatan dapat digunakan sebagai referensi utama maupun pendamping dalam proses pembelajaran keperawatan. Buku ini diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif, etis, dan humanis dalam memberikan pelayanan keperawatan di berbagai tatanan kesehatan.

Buku ajar Komunikasi Keperawatan membahas konsep, prinsip, dan penerapan komunikasi dalam praktik keperawatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami pentingnya komunikasi sebagai bagian utama dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif, profesional, dan berpusat pada pasien.

Isi buku ini mencakup pengertian dan tujuan komunikasi, unsur-unsur komunikasi, jenis-jenis komunikasi, prinsip komunikasi efektif, komunikasi terapeutik, teknik mendengarkan aktif, empati, sikap caring, serta penerapan komunikasi dalam hubungan perawat dengan pasien, keluarga, kelompok, dan tim kesehatan. Buku ini juga membahas hambatan komunikasi, etika dalam berkomunikasi, serta strategi komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus, seperti pasien anak, lansia, pasien dengan gangguan pendengaran, pasien cemas, pasien marah, maupun pasien dalam kondisi kritis.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa komunikasi bukan hanya proses menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan keterampilan profesional yang membutuhkan kepekaan, kesabaran, empati, dan tanggung jawab. Komunikasi yang baik dapat membantu perawat menggali keluhan pasien, memberikan edukasi kesehatan, membangun rasa aman, serta meningkatkan kualitas hubungan terapeutik antara perawat dan pasien.

Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ajar Komunikasi Keperawatan dapat digunakan sebagai referensi utama maupun pendamping dalam proses pembelajaran keperawatan. Buku ini diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif, etis, dan humanis dalam memberikan pelayanan keperawatan di berbagai tatanan kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-88-6 (PDF)

